Cuenta de Alto Costo

Fondo Colombiano de Enfermedades de Alto Costo

Resolución 0247 de 2014

Instructivo para el reporte de información CÁNCER

2026

Medición

2 de enero de 2025 al 1° de enero de 2026

Versión N° 1 | 13 Febrero de 2026

Emisión inicial

Elaboró	Coordinación de auditoría CAC
Revisó	Subdirecciones de gestión del riesgo y gestión del conocimiento CAC
Aprobó	Comité técnico

INSTRUCTIVO PARA FACILITAR EL REPORTE DE INFORMACIÓN DE CÁNCER DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 0247 DE 2014

Medición: 2 de enero del 2025 al 1º de enero del 2026

Este instructivo tiene como objetivo disponer las indicaciones y parámetros para que las entidades e instituciones prestadoras de servicios en salud (IPS)realicen la construcción de la información, seguimiento y gestión del riesgo en salud de la población con cáncer. En el desarrollo del documento se describen las poblaciones, fechas de actividades, variables, opciones de respuesta y aclaraciones. Ante cualquier inquietud registrarla mediante la mesa de ayuda en la plataforma SISCAC 4.0 con el detalle completo del caso.

El plazo máximo para presentar la información completa de la cohorte de cáncer es el 5 de mayo de 2026, las empresas administradoras de planes de beneficios en salud (EAPB) deben disponer la base de datos a la Cuenta de Alto Costo (CAC) mediante la plataforma SISCAC4.0 conforme los pasos que se describen en el manual de auditoría para este periodo.

Las poblaciones para reportar son:

Para la cohorte de cáncer se deben informar todas las personas con cáncer confirmado, y que presente cualquiera de los siguientes contextos:

- Las personas para reportar son aquellas con diagnóstico histopatológico confirmatorio de cáncer in situ o invasor y aquellas con diagnóstico clínico en manejo para cáncer, que se encontraban vivas y activas, fallecidas, y desafiliadas a la EAPB (incluidas las de régimen de excepción y las Direcciones Departamentales y Distritales de Salud) del 2 de enero de 2025 al 1° de enero de 2026.
- Todas aquellas que se encuentran en el seguimiento de la cohorte y que tienen validación previa del diagnóstico de cáncer por la CAC, con los datos históricos del diagnóstico según corresponda y las atenciones en salud brindadas en el periodo establecido.
- Los casos que presentaron inconsistencia de “cáncer diferente al reportado” en el periodo anterior, los cuales deben ser informados con el diagnóstico correcto, basados en el tipo histológico y localización determinada. Los pacientes a quienes luego de ser estudiados, se les confirmó la enfermedad maligna, pero en el periodo inmediatamente anterior, fueron marcados con la causal de “tumor en estudio o sospecha” o “sin sustento de diagnóstico, pero que recibieron tratamiento para el manejo de cáncer”, los cuales son identificados como casos nuevos para el objeto de la auditoría.
- Los usuarios con diagnóstico confirmado de cáncer que tuvieron trasladados entre EAPB para el periodo mencionado.

- Los usuarios con diagnóstico de cáncer confirmado en periodos previos a la presente medición y que no hayan sido reportados a la fecha la CAC. En estos casos puede ocurrir que no se cuente con los datos completos para las variables del momento del diagnóstico (fechas, estadificación y/o clasificación del riesgo), por lo cual se debe garantizar un dato válido para la fecha del diagnóstico y de reporte de patología (variables 18 y 24 respectivamente), no pueden tener comodín 1800-01-01. El soporte válido para estos casos es la historia clínica del especialista tratante en la que se detalle de manera completa el diagnóstico, reporte de patología, evolución de la enfermedad y tratamiento del cáncer reportado. No serán válidos soportes de medicina general, medicina familiar ni especialidades no relacionadas con el diagnóstico del cáncer, tampoco soportes de atenciones que mencionan antecedente de cáncer sin información que sustente el diagnóstico ni el tratamiento.

Es fundamental que se disponga el reporte de histopatología (básica e inmunohistoquímica según aplique), para la totalidad de los casos reportados por primera vez a la CAC; si el diagnóstico histopatológico se llevó a cabo durante el periodo (2 de enero de 2025 al 1 de enero 2026), el no contar con el soporte de análisis de patología generado por la IPS que proceso la muestra o su descripción detallada en la historia clínica será objeto de inconsistencia.

En los casos reportados por primera a la CAC (nuevos) y en los cuales las variables relacionadas con el momento del diagnóstico (var18 a var39) cuenten con opción de respuesta no realizado o datos desconocidos, en el proceso de calidad de los datos serán calificados como datos no gestionados, excepto en los pacientes con diagnóstico de cáncer anterior al 2015-01-01 y después del 2025-11-01. Aclaramos, la clasificación de calidad como datos no gestionados en las variables del diagnóstico no aplica para los pacientes con tipo requerido “activocac”, ya que en estos las variables del diagnóstico fueron validadas en periodos previos y son datos que no cambian, y en el periodo actual se verifica la información del tratamiento y seguimiento en el periodo, ya que.

Los pacientes con diagnóstico de cáncer confirmado por histopatología a partir del 1 de noviembre de 2025 que no alcanzaron a tener la estadificación del tumor, clasificación del riesgo, o primera consulta en la que se define el manejo terapéutico, Gleason, en los pacientes con cáncer de próstata ni HER2 en los de cáncer de mama, reportar en las variables 26, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38 y 39 la opción de respuesta 1800-01-01 y 99 según corresponda. Así mismo, una vez obtenida la información para el próximo periodo, deben realizar la debida actualización en los datos reportados como desconocidos (99 o 1800-01-01), lo cual únicamente es válido, si el diagnóstico se llevó a cabo a partir del 2025-11-01.

Los casos que en periodo previos ya tuvieron validación del diagnóstico confirmado de cáncer por parte de la CAC y que en la base de datos de requeridos tiene el tipo requerido “activocac”, deben ser informados con los datos históricos por tipo de cáncer en las variables del diagnóstico (variable 17 a la 40). Únicamente, se considera válida la modificación de las variablesHER2 para

pacientes con diagnóstico de cáncer de mama, ya que obtener un resultado positivo tras un nuevo estudio de inmunohistoquímica, cambia por completo el contexto del tratamiento. En caso de que la entidad, realice el reporte de información con ajustes en los datos históricos del diagnóstico, informamos que durante la auditoría se aplicaran lo ajustes a dicha información retornado los valores de las variables de diagnóstico a la información histórica para el tipo de cáncer, y generando datos de no calidad.

Los usuarios que previo al fallecimiento se encontraban en estudio por sospecha de cáncer, y posterior a la muerte se obtiene la confirmación, son objeto de reporte a la CAC. Es importante aclarar, que, para este tipo de casos, es imprescindible contar con la historia clínica previa en la que se sustenta la sospecha del cáncer, sumado al reporte histopatológico y los soportes válidos que permitan constatar el fallecimiento (historia clínica para muertes intrahospitalarias y/o certificado de fallecimiento).

Para los pacientes fallecidos antes o durante el periodo actual, se deben reportar con los últimos datos que se encuentren registrados en la historia clínica y en la variable 128 seleccionar la opción 4 o 10 según corresponda.

Los pacientes requeridos como “activoscac” que en el periodo de reporte actual describan en los soportes clínicos una especificación del diagnóstico de cáncer previamente reportado, y genere un cambio de agrupador de acuerdo con la clasificación del archivo operativo CIE-10 CAC, deben ser reportados en dos líneas; la primera sin ajuste en la variable 17 y con la novedad administrativa (var128 con la opción 16) y la segunda línea, con el diagnóstico actualizado en la variable 17, el tratamiento que recibió en el periodo de reporte actual y la novedad administrativa que corresponda en la variable 128; por ejemplo, en el periodo 2025-01-01 un caso fue reportado con el CIE-10 C919:Leucemia linfoide, sin otra especificación, pero en los soportes clínicos para el periodo actual, el profesional tratante define el linaje de la leucemia, tratándose de C910:Leucemia linfoblástica aguda, por lo cual cambió de agrupador de cánceres no priorizados a cánceres priorizados.

Para tener en cuenta en la base de datos:

Cada registro o fila de la base de datos es una persona y cada variable es una pregunta acerca de la persona. Todas las variables de esa persona deben registrarse en esa misma fila, si tiene dos o más cánceres primarios de forma simultánea o precedente en seguimiento, se debe reportar una fila para cada tipo de cáncer. En las variables 42, 43 y 44 registrar la información del otro cáncer primario y en la variable 128 (novedad administrativa) reportar los registros con opción 12 (usuario que es notificado con dos o más cánceres en este periodo), a excepción de los casos en que el paciente presente como novedad de desafiliado o fallecido, que son predominantes frente a la novedad descrita. La entidad debe identificar este contexto y en la base de datos antes de auditoría es responsable de verificar si las líneas del paciente fueron marcadas como duplicado,

de lo contrario debe informar al proceso de auditoría conforme lo establece el manual de auditoría.

La base de datos a reportar contiene 134 variables y corresponden a las definidas en el Anexo Técnico de la Resolución 0247/2014 que se reportan en 168 campos, la estructura para la disposición de la información se encuentra disponible en la plataforma SISCAC 4.0, así como, los archivos operativos y herramientas para orientar el reporte de información.

Toda la información reportada en la base de datos debe ser grabada como texto en archivos planos de formato ANSI, con extensión .txt y los separadores de las variables deben ser tabulaciones. No debe faltar ningún campo de los definidos en la tabla del anexo técnico de la resolución 0247/2014 y ninguna variable debe venir vacía, de lo contrario, el aplicativo rechaza el cargue de la información. No se debe usar ningún carácter especial en ninguno de los campos (&, ñ, ú –tildes-, ü –diéresis-, # -número-, ° -grado-, ´-apostrofe-, entre otros) ni se les debe completar con espacios.

El formato del nombre del archivo es AAAAMMDD_CODEAPB_CANCER.txt, en el cual AAAAMMDD corresponde a la fecha de reporte definida en el artículo 7 de la Resolución y CODEAPB al código de seis caracteres o el código del departamento o distrito según DIVIPOLA en caso de las entidades departamentales y distritales de salud, es decir, 20260505_CODEAPB_CANCER.txt

Los entes territoriales deben reportar toda la información de la población pobre no asegurada y de la población asegurada, a quien el ente territorial le suministró atenciones en salud para el manejo del cáncer durante el periodo de reporte.

La validación de los datos se debe realizar a través de la plataforma SISCAC4.0 conforme lo descrito en el manual de auditoría, por lo cual las EAPB deben consultar dicho documento para cumplir con las fases del proceso de auditoría establecido. El plazo máximo para el cargue de la información es el 5 de mayo de 2026 y el plazo máximo para disponer los soportes para la auditoría es el 12 de mayo de 2026.

IDENTIFICACIÓN GENERAL DE LA EAPB Y DEL USUARIO REPORTADO

A continuación, las variables relacionadas con la identificación de las personas y demografía de cada registro.

1. Primer nombre del usuario: Escriba el primer nombre del usuario, según el registrado en BDUA. Utilice letras mayúsculas. No se pueden utilizar símbolos, puntos, tildes, ni el carácter numeral, ni ningún otro carácter especial. Verifique que no esté registrando los datos del primer apellido en este campo, se considera un error.

2. Segundo nombre del usuario: Escriba el segundo nombre del usuario, según el registrado en BDUA. En caso de un tercer nombre, escríbalo separado por un espacio. Registre NONE, en mayúscula sostenida, cuando el usuario no tiene segundo nombre (NONE Ningún Otro Nombre Escrito). No se pueden utilizar símbolos, puntos, tildes, -, ni el carácter numeral, ni ningún otro carácter especial. Verifique que no esté registrando el primer nombre en este campo, se considera un error.

3. Primer apellido del usuario: Escriba el primer apellido del usuario, según el registrado en BDUA. Utilice letras mayúsculas. No se pueden utilizar símbolos, puntos, tildes, -, ni el carácter numeral, ni ningún otro carácter especial. Verifique que no esté registrando el primer apellido en lugar del primer nombre.

4. Segundo apellido del usuario: Escriba el segundo apellido del usuario según el registrado en BDUA. Registre NOAP, en mayúscula sostenida, cuando el usuario no tiene segundo apellido (NOAP: Ningún Otro Apellido)

Aclaraciones
Nombres y apellidos: es responsabilidad de la entidad registrar los nombres y apellidos de forma completa, tal como se encuentran en el sistema de afiliación y en el campo que corresponde. En la auditoría se evidencia que escriben el nombre del paciente en el campo del apellido y viceversa, contexto que es incorrecto y que genera reprocesos en el seguimiento e identificación de duplicados de la cohorte nacional.

5. Tipo de Identificación del usuario:
CC: Cédula ciudadanía
CE: Cédula de extranjería
CD: Carné diplomático
PA: Pasaporte
SC: Salvoconducto de permanencia
PT: Permiso temporal de permanencia
PE: Permiso Especial de Permanencia
RC: Registro civil
TI: Tarjeta de identidad
CN: Certificado de nacido vivo
AS: Adulto sin identificar (solo para el Régimen Subsidiado)
MS: Menor sin identificar (solo para el Régimen Subsidiado)
DE: Documento extranjero
SI: Sin identificación

6. Número de Identificación del usuario: Número de identificación del afiliado según el tipo de identificación. Para MS y AS registre el consecutivo interno del afiliado según lo dispuesto en la Resolución 4622/2016.

7. Fecha de nacimiento: Registre la fecha de nacimiento del usuario en el formato AAAA-MM-DD, según lo registrado en BDUA. Verifique que el orden de los números sea AÑO-MES-DÍA (AAAAMM-DD) y el separador entre estos sea "-"(guion). La fecha de nacimiento no puede ser posterior a la fecha de afiliación y debe ser anterior a la fecha de corte del reporte (2026-05-05).

8. Sexo: Indique el sexo de la persona reportada:
M: Masculino
F: Femenino

9. Ocupación: código según la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones, registre:
9999: No existe información
9998: No Aplica

10. Régimen de afiliación al SGSSS:
C: Régimen Contributivo
S: Régimen Subsidiado
P: Regímenes de excepción
E: Régimen especial
N: No asegurado
I: Fondo Atención en Salud para PPL

11. Código de la EAPB o de la entidad territorial: Cuando el usuario tenga EAPB escriba el código de la empresa que registra al usuario. Cuando el usuario sea notificado por entidad territorial escriba el código de departamento y seguido de tres ceros Ej: 01000 donde 01 corresponde al código de departamento según DANE.

12. Código pertenencia étnica: registre el grupo étnico del usuario:
1: Indígena
2: ROM (gitano)
3: Raizal del archipiélago de San Andrés y Providencia
4: Palenquero de San Basilio
5: Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente
6: Ninguna de las anteriores

13. Grupo poblacional:
1: Indigentes

2: Población infantil a cargo del ICBF
3: Madres comunitarias
4: Artistas, autores, compositores
5: Otro grupo poblacional
6: Recién Nacidos
7: Persona en situación de discapacidad
8: Desmovilizados
9: Desplazados
10: Población ROM
11: Población raizal
12: Población en centros psiquiátricos
13: Migratorio
14: Población en centros carcelarios
15: Población rural no migratoria
16: Afrocolombiano
31: Adulto mayor
32: Cabeza de familia
33: Mujer embarazada
34: Mujer lactante
35: Trabajador urbano
36: Trabajador rural
37: Víctima de violencia armada
38: Jóvenes vulnerables rurales
39: Jóvenes vulnerables urbanos
50: Persona en situación de discapacidad del sistema nervioso
51: Persona en situación de discapacidad de los ojos
52: Persona en situación de discapacidad de los oídos
53: Persona en situación de discapacidad de los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto)
54: Persona en situación de discapacidad de la voz y el habla
55: Persona en situación de discapacidad del sistema cardiorrespiratorio y las defensas
56: Persona en situación de discapacidad de la digestión, el metabolismo, las hormonas
57: Persona en situación de discapacidad del sistema genital y reproductivo
58: Persona en situación de discapacidad del movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas
59: Persona en situación de discapacidad de la piel
60: Persona en situación de discapacidad de otro tipo
61: No definido
62: Comunidad indígena
63: población migrante de la República Bolivariana de Venezuela

14. Municipio de residencia: Registre el Código del municipio en donde reside el afiliado según la división político-administrativa DIVIPOLA – DANE. Este código debe ser reportado en 5 dígitos, en el cual los dos primeros dígitos corresponden al departamento donde se localiza el municipio. Validar que no se reporte la ciudad en la que recibe las atenciones en salud, cuando es en realidad reside de otro municipio.

15. Número telefónico del paciente (incluyendo a familiares y cuidadores): Registre sólo dos números de teléfono(s) fijos y/o móviles completos para contactar al paciente y separe por guion medio (-). Si no se tiene el número telefónico del paciente (incluyendo familiares y cuidadores) diligencie 0.

16. Fecha de afiliación a la EAPB que reporta: Fecha en la que el usuario se afilió a la EAPB en el formato AAAA-MM-DD (use como separador el guion "-").

Aclaraciones
*Para las EPS (contributivo y subsidiado), la fecha de afiliación se verifica con el resultado de la fuente oficial BDUA. *Para las entidades del régimen especial, excepción y entes territoriales, deben disponer el soporte del certificado de afiliación. *Si el paciente es reportado por un ente territorial de salud, la fecha que se debe diligenciar corresponde a la fecha en la que la entidad territorial identificó que se trata de una persona pobre no asegurada o la fecha en la cual se le prestó al paciente servicios no incluidos en el plan de beneficios *Si una entidad cambia de razón social, se debe reportar como fecha de afiliación del paciente, la fecha de creación de la nueva razón social. *La fecha de afiliación en EPS del régimen contributivo o subsidiado debe ser superior a 1995- 01-01. *La fecha de afiliación a informar en esta variable corresponde a la afiliación dentro del periodo, es decir, si un paciente está afiliado desde el 2018 a la entidad de manera continua y sin interrupciones, esa es la fecha para reportar. Ahora bien, si el paciente durante el periodo tiene afiliación con interrupciones, debe reportar la fecha de afiliación inicial del periodo que actualmente lo reporta activo.

INFORMACION RELACIONADA A DIAGNÓSTICO, ESTADIFICACIÓN Y OBJETIVO DEL TRATAMIENTO INICIAL

Las variables 17 a la 44 se encuentran relacionadas con el momento del diagnóstico del cáncer, recuerde que cada lesión neoplásica primario se debe registrar en una línea con sus respectivos datos del diagnóstico.

17. Código CIE - 10 de la neoplasia (cáncer o tumor) maligna reportada (primario): Registré el código de la enfermedad maligna que fue inicialmente diagnosticada al usuario según código CIE -10, (archivo operativo disponible en la plataforma SISCAC). Sí el paciente tuvo inicialmente diagnóstico clínico que posteriormente fue confirmado con histopatología, en esta variable debe registrar el CIE-10 de la confirmación histopatológica.

Aclaraciones
* Las metástasis a otros órganos no aplican como segundo primario por lo que no deben ser reportadas en filas independientes. Las metástasis que se identifican desde el diagnóstico se incluyen en la estadificación del tumor en la variable 29. * En la variable 17 se registra solo el tumor primario y los tumores secundarios (metástasis) con primario desconocido, dispuestos en el archivo operativo CIE-10 en el agrupador "tumores secundarios" eligiendo el que más se adecúe según el compromiso. * No se considera válido el uso del código "C80X Tumor maligno de sitios no especificados", eliminado del archivo operativo. En caso de tener pacientes históricos con dicho diagnóstico por favor verificar para que realice el ajuste del código CIE-10 * Pueden encontrarse en las historias clínicas diferentes CIE-10 del mismo tumor primario siendo del mismo agrupador (ver archivo operativo disponible en la plataforma SISCAC) y del mismo tipo histológico, por lo cual la entidad y la IPS deben verificar si se trata de uno o más primarios, y reportar según corresponda. ***** Si el paciente presenta en el mismo órgano dos primarios diferentes, se deben reportar de manera independiente (cada uno en una fila); por ejemplo, cáncer de piel con lesiones múltiples, o cáncer de mama un primario en cada mama. * Dentro de cáncer de cuello uterino, deben ser reportadas todas las pacientes con confirmación de cáncer in situ o infiltrante, a partir de la histopatología obtenida por colposcopia o conización. No es válido el reporte como caso confirmado, la información obtenida a partir de la citología cérvicouterina. Para casos descritos en el reporte de patología como lesiones de alto grado, es indispensable la descripción explícita del componente in situ (carcinoma o adenocarcinoma in situ), para ser considerado válidos. Si se van a reportar por primera vez pacientes con diagnóstico antiguo que según anterior clasificación se definen como NIC III, de igual manera es indispensable que el patólogo describa el compromiso por carcinoma in situ para considerarse objeto de reporte. En los casos que el soporte de atención oncológica mencione que el diagnóstico es cáncer de cuello uterino in situ se válida para la auditoria, a pesar de que el reporte de patología describa NIC III. * Dentro de la enfermedad de Paget, son objeto de reporte como cáncer de mama, las lesiones que comprometan el tejido mamario profundo (lóbulos, lobulillos o conductos); los

tumores que sólo comprometen la piel del pezón y la areola deben ser reportados como cáncer de piel (cáncer no priorizado).

* Para el caso de los tumores Phyllodes (filodes), sólo son objeto de reporte aquellos que tengan descripción histopatológica como Phyllodes de alto grado o maligno (por mención explícita del patólogo o por la descripción de 10 o más mitosis por campo de alto poder), los demás tumores serán considerados lesiones benignas, las cuales no son objeto de reporte.

* Los tumores del estroma gastrointestinal (GIST), son sarcomas localizados en cualquier porción del sistema gastrointestinal (más comúnmente estómago), los cuales deben ser reportados como tumores de tejidos blandos y tejidos conjuntivos.

* Los adenomas en el intestino cuando son vellosos y tienen displasia son predictivos de cáncer, por lo cual es importante su notificación en el programa de detección temprana para dar seguimiento a la evolución de la enfermedad. No se notifican a la CAC hasta tanto no se cuente con reporte de patología in situ o infiltrante para diagnóstico de cáncer. En el manejo de los adenomas se debe realizar resección y evaluar el componente in situ. (comité de expertos 2023)

***** Los tumores de la unión gastroesofágica, deberán ser reportados con un CIE-10 del agrupador de estómago cuando su histología corresponda a adenocarcinoma; en caso de ser del tipo escamocelular, deberá ser reportado como esófago. Vale la pena aclarar, que, si el tumor se ubica en el tercio medio o superior del esófago, independiente de su histología, corresponde a un cáncer esofágico y no gástrico.

* Los tumores neuroendocrinos (TNE) grado I, II o III son objeto de reporte; el CIE-10 indicado para este tipo de lesiones es C759 Tumor maligno de glándula endocrina no especificada, independiente del órgano de origen.

***** Todos los astrocitomas en población pediátrica y adulta independiente del grado OMS deben ser reportados (agrupador “ojo, encéfalo, y otras partes del sistema nervioso”).

* Las histiocitosis correspondientes al grupo M (histiocitosis primaria maligna e histiocitosis secundaria maligna) y las del grupo L (histiocitosis de células de Langerhans, enfermedad de Erdheim-Chester, histiocitosis de células indeterminadas y la histiocitosis mixta (células de Langerhans/enfermedad de Erdheim-Chester) son objeto de reporte a la cohorte de cáncer. ***No osbtante, no son objeto de reporte las histiocitosis netamente cutáneas.*** Los CIE-10 dispuestos en el archivo operativo para tal fin son C960, C961, D760, C965 o C966, lo cual será contrastado con los soportes durante la auditoría.

* Si la histología obtenida corresponde a un blastoma, la selección del código CIE-10 dependerá del órgano en él se origina (SNC, peritoneo, pulmón, mediastino, etc.)

* Los pacientes con diagnóstico de mastocitosis objeto de reporte, son aquellos con confirmación de mastocitosis sistémica (por compromiso medular o de órganos extra cutáneos demostrada, a partir de la presencia de mastocitos anormales en la médula ósea y clonalidad claramente definidas). ***No son objeto de reporte pacientes con mastocitosis netamente cutánea.***

***** Todos los sarcomas de tejidos blandos, tales como rabdomiosarcomas, liposarcomas, sarcomas puros, angiosarcomas entre otros, deben ser reportados en el agrupador de "tejidos blandos y tejidos conjuntivos". Por otro lado, los sarcomas del hueso, el cartílago o la articulación, corresponden al agrupador de "huesos y cartílagos articulares". Si el paciente tiene diagnóstico de sarcoma de Ewing, elegir el agrupador según corresponda a un sarcoma de Ewing óseo (hueso y cartílagos articulares) o extraóseo (tejidos blandos y tejidos conjuntivos).

* Los dermatofibrosarcomas son una excepción importante, ya que deben ser reportados como tumores de piel.

* Si se trata de un tumor in situ según reporte histopatológico inicial, se debe elegir el CIE-10 correspondiente en el archivo operativo, que inicié con la letra D y el estadio (0 o in situ) debe coincidir en la variable 29.

* Los códigos de CIE10 fueron revisados en el periodo 2022 y se inactivaron códigos relacionados con descripciones no específicas del tipo de cáncer y reclasificación de linfomas, por lo cual la entidad debe revisar el archivo operativo de CIE-10 y las observaciones para los diagnósticos, ya que existen códigos CIE-10 que no deben ser usados en el reporte en los pacientes notificados por primera vez a la CAC, lo cuales se deben notificar con los códigos que correspondan a la enfermedad.

*El diagnóstico de cáncer tiroides es patológico, se confirma con el resultado de reporte de biopsia postquirúrgica. ***El resultado de categoría Bethesda III a V NO es confirmatoria del cáncer***, aun cuando se describa carcinoma, por tanto, estos pacientes serán objeto de intervención quirúrgica y biopsia postquirúrgica para confirmación diagnóstica. Para estos casos, la cirugía funciona como diagnóstico y tratamiento. En caso de tener un Bethesda VI y el especialista define que no habrá procedimiento quirúrgico por razones específicas, pero interpreta el caso con malignidad confirmada, será válido.

*No hay diagnóstico clínico en linfomas, se requiere de confirmación de inmunofenotipo mediante IHQ. La biopsia básica, puede confirmar malignidad sin confirmar el subtipo específico.

* La leucemia linfocítica crónica (LLC), según la Clasificación de Tumores Hematopoyéticos y Linfoides de la OMS 2016, forma parte del grupo de los linfomas no Hodgkin de células maduras o linfomas linfocíticos

*Macroglobulinemia de Waldestrom, C880 (24= Otros tumores malignos del tejido linfático). No debe ser reportado como linfoma, tiene CIE-10 propio Trastorno linfoproliferativo de fenotipo B infrecuente, que se define por la presencia de infiltración de médula ósea por un linfoma linfoplasmocitoide, asociado a una paraproteinemia IgM (monoclonal).

*Enfermedad de Castelman, C778 (14. Tumores secundarios). No debe ser reportado como linfoma, es un desorden linfoproliferativo poco frecuente y de patogenia desconocida, comúnmente asociado a infección por VIH y herpes; puede ser localizada (único ganglio) o diseminada.

* La micosis fungoide es el tipo más común de linfoma cutáneo de células T, un cáncer que se origina en los linfocitos T y se manifiesta predominantemente en la piel. Pertenece al agrupador 9= CAC Linfoma No Hodgkin.

*Las siguientes lesiones de piel no son objeto de reporte a la CAC debido a que son benignas: Lesiones benignas no objeto de reporte: nevus de spitz, nevus azul, nevus recurrente, queratosis seborreica, queratosis actínica, lago venoso, angioqueratomas, melanonis de vulva y pene, nevus melanocítico, lentigo simple, lentigo solar, lentigo labial y dermatofibroma.

* Los tumores de esófago, y duodeno hacen parte del agrupador “otros órganos digestivos”.

*Diagnósticos diferenciales malignos que corresponden a un agrupador diferente al de estómago: Linfoma no Hodgkin en estómago, tumores del estroma gastrointestinal (GIST), leiomiosarcoma, tumor carcinoide de estómago (es neuroendocrino) y tumores neuroendocrinos.

*En los tumores de apéndice no es objeto de reporte el adenoma/Cistadenoma mucinoso (CM).

* En cáncer de colon y recto se incluyen los tumores originados en toda la extensión del colon (incluyendo el apéndice originado en el ciego), recto y conducto anal.

* Los tumores del intestino delgado no hacen parte del cáncer colorrectal, sino del agrupador “Otros órganos digestivos”.

duplicidad de registros, reportar un diagnóstico sin tener soportes suficiente, errores en la codificación y clasificación de la patología

18. Fecha de diagnóstico del cáncer reportado: Escriba la fecha de diagnóstico en formato AAAA-MM-DD (con guion "-" como separador). Si conoce sólo el año y el mes, registre el día 15.

Registre 1800-01-01: Desconocido, el dato de esta variable no se encuentra descrito en los soportes clínicos.

Aclaraciones
*Cuando el diagnóstico fue histopatológico la fecha de la variable 18 es igual a la fecha de la variable 24; para todo paciente reportado por primera vez, se debe adjuntar el reporte de histopatológico para sustentar dichas variables. *Cuando el diagnóstico del cáncer fue clínico (no se realizó histopatología), registre la fecha de la primera consulta en la que el especialista basado en reportes imagenológicos y/o de laboratorio, concluye que se trata de un diagnóstico de cáncer. *Para los casos en que se realiza un diagnóstico clínico inicial y en ésta misma fecha se indica tratamiento específico, ésta fecha es la que corresponde a variables 18 y 26; si más adelante se obtiene el reporte histopatológico, se registra este nuevo dato de fecha en la variable 24, es decir, será posterior a la fecha de diagnóstico e indicación de tratamiento. Ejemplo: Paciente con diagnóstico de síndrome linfoproliferativo (no hay confirmación por citometría de flujo (CMF) a la fecha), que, por su condición clínica y riesgo, el hemato-oncológo tratante indica inicio de terapia sistémica, confirmando con CMF el diagnóstico C910 (Leucemia linfoide aguda) 7 días más tarde. *Es otro el caso, de los cánceres que sólo pueden ser confirmados por patología, como por ejemplo el cáncer de tiroides o de piel, por tanto, el dato de la variable 18, es el mismo de la variable 24.

19. Fecha de la nota de remisión o interconsulta del médico o institución general hacia la institución o médico que hizo el diagnóstico: Revisar en la historia clínica la remisión más antigua disponible previa al diagnóstico y que pudiese estar asociada a la enfermedad maligna actual (debe ser menor o igual a la fecha de ingreso a la institución que realizó el diagnóstico, solicitada en la variable 20). Escriba la fecha de esa remisión en formato AAAA-MM-DD (con guion "-" como separador). Si conoce sólo el año y el mes, registre el día 15.

Registre 1800-01-01: Desconocido, el dato de esta variable no se encuentra descrito en los soportes clínicos.

Aclaraciones
*Para los casos en que la sospecha de enfermedad maligna está basada en imágenes, por ejemplo, TAC con evidencia de masa pulmonar sospechosa, resonancia para tumores del SNC, endoscopia alta o baja para tracto gastrointestinal, mamografía para cáncer de mama, etc., es

válido tomar la fecha del reporte de dicho estudio en esta variable. Es imperativo que, en estos casos, se anexe el reporte correspondiente, como parte de los documentos dispuestos para la auditoría. Lo anterior, también aplica ante hallazgos sospechosos a partir de estudios de tamización.

*En los casos en que no se cuenta con la fecha exacta de remisión, reporte del estudio imagenológico o de tamizaje, registre la fecha en la que fue ordenado el estudio con el que se pretende confirmar la sospecha de cáncer, es decir, la fecha en que ordenan la biopsia, imagen o laboratorio.

20. Fecha de ingreso a la institución que realizó el diagnóstico luego de la remisión o interconsulta: Registre la fecha en formato AAAA-MM-DD. Si conoce sólo el año y el mes, registre el día 15.
Registre 1800-01-01: Desconocido, el dato de esta variable no se encuentra descrito en los soportes clínicos.

Aclaraciones
*Sí el diagnóstico del cáncer fue clínico registre la fecha de la atención en la que se hace el diagnóstico clínico de la lesión neoplásica. La variable 18 es igual a la variable 20 en este caso. *Sí el diagnóstico del cáncer fue por histopatología registre la fecha en que la muestra de patología ingresa al laboratorio que realiza el procesamiento. *En los casos en que el reporte de patología no registra fecha de ingreso de la muestra al laboratorio, registre la fecha en la que fue ordenado el estudio con el que se pretende confirmar la sospecha de cáncer, es decir, la fecha en que ordenan la biopsia, imagen o laboratorio, lo cual debe de estar soportado con la nota médica donde se constate dicha solicitud. * Si la lesión del cáncer se confirma con el reporte de análisis de la patología, se debe registrar la fecha en que ingreso la muestra de patología al laboratorio que lo proceso, así haya requerido posteriormente una inmunohistoquímica. *Igualmente, si la lesión del cáncer no se confirma con el reporte de análisis de la patología, pero luego se confirma en la inmunohistoquímica, se toma la misma fecha en que ingreso la muestra al laboratorio, independiente del análisis realizado.

21. Tipo de estudio con el que se realizó el diagnóstico de cáncer: tipo de prueba registre:

5: Inmunohistoquímica
6: Citometría de flujo
7: Clínica exclusivamente (incluye estudios imagenológicos y/o de laboratorio en aquellos casos clínicamente justificados en donde fue imposible tomar muestra de estudio histopatológico)
8: Otro
9: Genética
10: Patología básica
99: Desconocido, el dato de esta variable no se encuentra descrito en los soportes clínicos.

Aclaraciones
* Para los pacientes anteriores (antiguos) y que fueron reportados antes del 2020, las opciones de respuesta 1, 2, 3 y 4 son válidas, ya que hacen parte del histórico. Actualmente, en el instructivo estas opciones no se encuentran y no son válidas para pacientes reportados por primera vez a la CAC (nuevos). * Las opciones de respuesta 1, 2, 3 y 4 se eliminaron y quedan incluidas en la opción 10, sólo están habilitadas en usuarios prevalentes (reportados antes del 2020) como parte de dato histórico. *Registre el primer estudio que permitió confirmar el cáncer.

Para pacientes reportados por primera vez la CAC con diagnóstico de cáncer: seleccionar la opción que corresponda:
5: Inmunohistoquímica
6: Citometría de flujo
7: Clínica exclusivamente (incluye estudios imagenológicos y/o de laboratorio en aquellos casos clínicamente justificados en donde fue imposible tomar muestra de estudio histopatológico)
8: Otro
9: Genética
10: Patología básica

22. Motivo por el cual el usuario no tuvo diagnóstico por histopatología (aplica para registros con respuesta igual a 7 en la variable anterior):

1: Clínica, usuario con coagulopatía
2: Clínica, debido a localización del tumor
3: Clínica, debido al estado funcional del usuario (deterioro)
4: Negativa del usuario o su acudiente para realizar el estudio histopatológico, con documentación de soporte
5: Administrativa
6: Clínica por reporte de imágenes o laboratorios.
98: Tiene confirmación por histopatología.
99: Desconocido, el dato de esta variable no se encuentra descrito en los soportes clínicos.

23. Fecha de recolección de muestra para estudio histopatológico de diagnóstico: Registre la fecha en el formato AAAA-MM-DD. Si conoce sólo el año y el mes, registre el día 15.
Registre 1800-01-01: Desconocido, el dato de esta variable no se encuentra descrito en los soportes clínicos.
Registre 1845-01-01: No se realizó estudio histopatológico (en la variable 21 registro la opción 7).

Aclaraciones
*Para los casos en los que la muestra con la que se confirma el diagnóstico es producto de una cirugía, reporte en esta variable la fecha de la cirugía. (Ejemplo: cáncer de tiroides, piel, entre otros). *Los soportes válidos para esta variable son la nota quirúrgica o de procedimiento, o el reporte de patología que incluya la fecha de recolección de la muestra, no es válida la fecha de ingreso de la muestra al laboratorio para su procesamiento.

24. Fecha de primero o único informe histopatológico válido de diagnóstico: Registre la fecha en el formato AAAA-MM-DD. (Registre la fecha de la primera prueba que confirmó diagnóstico de cáncer e inició un manejo, así haya requerido pruebas adicionales posteriormente para el diagnóstico definitivo). Si conoce sólo el año y el mes, registre el día 15.

Registre 1800-01-01: Desconocido, el dato de esta variable no se encuentra descrito en los soportes clínicos.
Registre 1845-01-01: No se realizó estudio histopatológico (en la variable 21 registro la opción 7).

Aclaraciones
*En el cargue de soportes es obligatorio adjuntar el reporte del resultado del análisis de la patología para dar respuesta a esta variable.

25. Código válido de habilitación de la IPS donde se realiza la confirmación diagnóstica: Registre el código de habilitación (disponible en la página web REPS – código de 12 dígitos incluido el cero inicial) de la IPS que proceso la muestra de patología en los casos en que el diagnóstico fue histopatológico o registre el código de la IPS donde se hizo el diagnóstico clínico. Verifique que el código reportado corresponde a una IPS con habilitación para procesamiento de muestra de patología o el servicio especializado que hace el diagnóstico clínico.

96: Diagnóstico fuera del país.
99: Desconocido, el dato de esta variable no se encuentra descrito en los soportes clínicos.

Aclaraciones
*Para diagnósticos histopatológicos llevados a cabo en el periodo, la IPS reportada debe estar habilitada en REPS para dicho servicio, de lo contrario, el auditor calificará como DOND. Este dato se extrae del reporte de patología original, el cual debe contener la sede responsable. *No es válido usar el código de la IPS de seguimiento o de tratamiento en esta variable.

26. Fecha de primera consulta con médico tratante de la enfermedad maligna (médico especialista que define la primera conducta terapéutica -terapia sistémica, cirugía, radioterapia o cuidados paliativos- Manejo expectante): Registre la fecha en el formato AAAA-MM-DD. Si conoce sólo el año y el mes, registre el día 15.

Registre 1800-01-01: Desconocido, el dato de esta variable no se encuentra descrito en los soportes clínicos.

Aclaraciones
*Para los usuarios con diagnóstico de cáncer histopatológico a partir del 1 de noviembre de 2025 y que no alcanzaron a tener la consulta en donde se define la primera conducta terapéutica, reportar en esta variable la opción 1800-01-01 y en la variable 128 la opción de novedad 2, 10 o 13 según corresponda. * Para los pacientes que tuvieron en el periodo el procedimiento quirúrgico que hace las veces de diagnóstico y tratamiento, es válido registrar la fecha de la realización del procedimiento en las siguientes variables: VAR23. Fecha de recolección de muestra para estudio histopatológico de diagnóstico, VAR26. Fecha de primera consulta con médico tratante de la enfermedad maligna, y VAR76. Fecha de realización de la primera cirugía en este periodo de reporte. Por ejemplo, ocurre con frecuencia en cáncer de piel y tiroides.

27. Histología del tumor en muestra de biopsia o quirúrgica: Registre el número que corresponde al subtipo histológico de la biopsia diagnóstica del cáncer (como primera opción), si no hay información en ese reporte use la quirúrgica:

1: Adenocarcinoma, con o sin otra especificación
2: Carcinoma escamocelular (epidermoide), con o sin otra especificación
3: Carcinoma de células basales (basocelular)
4: Carcinoma, con o sin otra especificación diferentes a las anteriores
5: Oligodendroglioma, con o sin otra especificación
6: Astrocitoma, con o sin otra especificación
7: Ependimoma, con o sin otra especificación
8: Neuroblastoma, con o sin otra especificación
9: Meduloblastoma, con o sin otra especificación
10: Hepatoblastoma, con o sin otra especificación
11: Rabdomiosarcoma, con o sin otra especificación
12: Leiomiosarcoma, con o sin otra especificación
13: Osteosarcoma, con o sin otra especificación
14: Fibrosarcoma, con o sin otra especificación
15: Angiosarcoma, con o sin otra especificación
16: Condrosarcoma, con o sin otra especificación
17: Otros sarcomas, con o sin otra especificación
18: Pancreatoblastoma, con o sin otra especificación

19: Blastoma pleuropulmonar, con o sin otra especificación
20: Otros tipos histológicos no mencionados
21= Célula pequeña (cáncer de pulmón)
23: Melanoma
24: Carcinoma papilar de tiroides
98: No se realizó estudio histopatológico (en la variable 21 registró la opción 7).
99: Desconocido, el dato de esta variable no se encuentra descrito en los soportes clínicos.

Aclaraciones
*Para los casos con subtipo histológico escamocelular (opción 2), este no sólo está reservado para el cáncer de piel, sino para todos los tumores reportados con esta histología (ejemplo: cérvix, pulmón, canal anal, etc.) *En los pacientes incidentes la opción 99 de esta variable será calificada como un dato no gestionado. *En el instructivo de reporte 2026, se incluye la opción 21: célula pequeña (únicamente valida para cáncer de pulmón).

28. Grado de diferenciación del tumor sólido maligno según la biopsia o informe de primera cirugía: Apunte el número que corresponde al grado de diferenciación de la biopsia diagnóstica del cáncer (como primera opción), si no hay información en ese informe, use la quirúrgica.

1: Bien diferenciado (grado 1)
2: Moderadamente diferenciado (grado 2)
3: Mal diferenciado (grado 3)
4: Anaplásico o indiferenciado (grado 4)
94: Es un cáncer sólido cuyo reporte de patología no incluye la descripción de la diferenciación celular. (ejemplo: cáncer de tiroides, carcinoma basocelular, tumores in situ, melanoma, próstata, entre otros).
95: No es sólido (cáncer hematolinfáticos)
98: No se realizó estudio histopatológico (en la variable 21 registró la opción 7).
99: No hay información en la historia clínica

Aclaraciones
*Recuerde que la puntuación de la escala de Nottingham da un resultado en grado 1, 2 o 3, el cual puede registrar en esta variable. *La opción 99 está reservada para los cánceres que sí deben tener grado de diferenciación, pero no está descrito en los soportes. *En los casos como cáncer de próstata con patología que no describa grado de diferenciación, reportarlos en opción 94, no realizar homologaciones a partir de la descripción del Gleason. *La opción 99 sólo es válida para diagnóstico antes de 2015-01-01, se aclara que, si el diagnóstico fue previo a la fecha mencionada, pero se tiene el dato solicitado entonces se debe reportar.

29. Si es tumor sólido, cuál fue la primera estadificación basada en TNM, FIGO, u otras compatibles con esta numeración según tumor:

CÁNCER DE MAMA Y CÁNCER GÁSTRICO
0: estadio clínico (ec) 0 (tumor in situ)
2: ec IA o 1A
5: ec IB o 1b
11: ec IIA o 2a
14: ec IIB
17: ec IIIA o 3a
18: ec IIIB o 3b
19: ec IIIC o 3c
20: ec IV o 4

CANCER DE PRÓSTATA
0: estadio clínico (ec) o (tumor in situ)
1: ec I o 1
11: ec IIA o 2a
14: ec IIB
15: ec IIC o 2c
17: ec IIIA o 3a
18: ec IIIB o 3b
19: ec IIIC o 3c
21: ec IVA o 4a
22: ec IVB o 4b

CANCER DE PULMÓN
8ª Edición TNM
0: estadio clínico (ec) o (tumor in situ)
3: ec IA1
4: ec IA2
36: ec IA3
11: ec IIA o 2a
14: ec IIB o 2b
17: ec IIIA o 3a
18: ec IIIB o 3b
19: ec IIIC o 3c
21: ec IVA o 4a
22: ec IVB o 4b

MELANOMA
0: estadio clínico (ec) o (tumor in situ)
2: ec IA o 1A
5: ec IB o 1b
11: ec IIA o 2a
14: ec IIB o 2b
15: ec IIC o 2c
17: ec IIIA o 3a
18: ec IIIB o 3b
19: ec IIIC o 3c
29: ec IIID o 3d
20: ec IV o 4

CÁNCER DE COLON Y RECTO
0: estadio clínico (ec) o (tumor in situ)
1: ec I o 1
11: ec IIA o 2a
14: ec IIB o 2b
15: ec IIC o 2c
17: ec IIIA o 3a
18: ec IIIB o 3b
19: ec IIIC o 3c
21: ec IVA o 4a
22: ec IVB o 4b
23: ec IVC o 4c

CÁNCER ANAL (Agrupador Colon y recto)
8ª Edición TNM
0: estadio clínico (ec) o (tumor in situ)
1: ec I o 1
11: ec IIA o 2a
14: ec IIB o 2b
17: ec IIIA o 3a
18: ec IIIB o 3b
19: ec IIIC o 3c
20: ec IV o 4

CÁNCER DE CÉRVIX (FIGO)
0: estadio clínico (ec) o (tumor in situ)
1: ec I o 1
2: ec IA o 1A

3: ec IA1
4: ec IA2
5: ec IB o 1b
6: ec IB1
7: ec IB2
30: ec IB3
10: ec II o 2
11: ec IIA o 2a
12: ec IIA1
13: ec IIA2
14: ec IIB o 2b
16: ec III o 3
17: ec IIIA o 3a
18: ec IIIB o 3b
19: ec IIIC o 3c
27: ec IIIC1
28: ec IIIC2
21: ec IVA o 4a
22: ec IVB o 4b
OTRAS OPCIONES
8: ec IC o 1c
9: ec IS o 1s
24: ec 4S (para neuroblastoma)
25: ec V o 5
31: ec IC1
32: ec IC2
33: ec IC3
34: ec IIIA1
35: ec IIIA2

98: No Aplica (Es cáncer de piel basocelular, es cáncer hematológico o es cáncer en SNC, excepto neuroblastoma).
99: Desconocido, el dato de esta variable no se encuentra descrito en los soportes clínicos.

Aclaraciones
*En caso de más de una estadificación (clínica, patológica, etc.), registre aquella que fue usada para iniciar el tratamiento o la primera registrada en la historia clínica al completar los exámenes de extensión. Escoja el número que representa la estadificación clínica. *Por otra parte, se presentan las opciones de estadificación por los agrupadores de cánceres priorizados; sin embargo, en los casos que esté reportando algún tipo de cáncer no priorizado

puede seleccionar la opción de respuesta que tenga registrada en el soporte clínico, sin tener presente el agrupador acá mencionado.

*Capturar la información descrita en la historia clínica en los casos en que la estadificación de la clasificación internacional no corresponde al agrupador mencionado.

*Para los usuarios con diagnóstico de cáncer histopatológico a partir del 1 de noviembre de 2025 y que no alcanzaron a tener la consulta en donde se estadifica el tumor, reportar en esta variable la opción 99 y en la variable 128 la novedad 2, 10 ó 13 según corresponda.

*Las opciones 34 y 35 como parte de la clasificación FIGO para cáncer de ovario, no son válidos en cérvix.

*La opción 99 en incidentes, será considerado gestión deficiente del dato

*Si en variable 17 se reportó un CIE-10 que inicia por letra D, es decir, cáncer in situ, el estadio a reportar en variable 29 debe ser coherente, es decir, opción 0: estadio clínico (ec) o (tumor in situ).

*En los casos que el especialista tratante para cáncer de próstata no consigne explícitamente el estadio TNM, y en el detalle de la historia clínica se encuentren documentados los valores de TNM, PSA y puntaje de Gleason, de acuerdo con la disponibilidad de la auditoría se realiza la captura del dato basándose en los criterios establecidos en la 8ª edición del AJCC. Esta situación genera datos de no calidad, por lo cual es la EAPB y la red de prestadores los responsables de garantizar el registro completo de los datos.

30. Fecha en que se realizó esta estadificación: Registre la fecha en el formato AAAA-MM-DD. Si conoce sólo el año y el mes, registre el día 15.

Registre 1800-01-01: Desconocido, el dato de esta variable no se encuentra descrito en los soportes clínicos.
Registre 1845-01-01: No Aplica (Es cáncer de piel basocelular, es cáncer hematológico o es cáncer en SNC, excepto neuroblastoma)

Aclaraciones
* Para los usuarios con diagnóstico de cáncer histopatológico a partir del 1 de noviembre de 2025 y que no alcanzaron a tener la consulta en donde se estadifica el tumor, reportar en esta variable la opción 1800-01-01 y en la variable 128 la novedad 2, 10 o 13.

31. Para cáncer de mama, ¿se le realizó a este usuario la prueba HER2 (llamado también receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano, también llamado erb-B2) antes del inicio del tratamiento?: Registre
1: Sí se le realizó

2: No se le realizó
97: No Aplica porque es cáncer de mama in situ
98: No Aplica (no es cáncer de mama)
99: Desconocido, el dato de esta variable no se encuentra descrito en los soportes clínicos

Aclaraciones
*Si se realizó el examen en pacientes con cáncer de mama in situ, capturar la información. *Se aclara que, si el HER2 efectivamente se realizó, pero éste fue posterior al inicio del tratamiento, la opción correcta en variable 31 es 2: No se realizó; sin embargo, en variables 32 y 33 se debe reportar la fecha y resultado de la prueba HER2 respectivamente.

32. Para cáncer de mama, fecha de realización de la única o última prueba HER2: Registre la fecha en el formato AAAA-MM-DD. Si conoce sólo el año y el mes, registre el día 15.

Registre 1800-01-01: Desconocido, el dato de esta variable no se encuentra descrito en los soportes clínicos
Registre 1840-01-01: No Aplica porque es cáncer de mama in situ.
Registre 1845-01-01: No Aplica (no es cáncer de mama) o marcó la variable 31 con la opción 2.

33. Para cáncer de mama, resultado de la única o última prueba HER2: Registre:
1: +++ (positivo)
2: ++ (equivoco o indeterminado)
3: + (negativo)
4: cero ó (negativo)
97: No Aplica porque es cáncer de mama in situ.
98: No Aplica (no es cáncer de mama) o marcó la variable 31 con la opción 2.
99: Desconocido, el dato de esta variable no se encuentra descrito en los soportes clínicos.

Aclaraciones
*Para pacientes prevalentes (anteriores, reportados en periodos previos), que producto de una nueva IHQ por ejemplo postquirúrgica, se obtenga un resultado diferente del HER2 (en especial si reporta positivo), el dato debe ser ajustado, ya que el enfoque del tratamiento puede variar.

34. Para cáncer colorrectal, estadificación de Dukes Registre**:**
1: A
2: B
3: C
4: D
98: No Aplica (no es cáncer colorrectal)
99: Es cáncer colorrectal pero no hay información en la historia clínica acerca de esta estadificación

35. Fecha en que se realizó la estadificación de Dukes: Registre la fecha en el formato AAAA-MM-DD. Si conoce sólo el año y el mes, registre el día 15.

Registre 1845-01-01: No Aplica (no es cáncer colorrectal o respuesta 99 en la variable anterior)

36. Estadificación clínica en linfoma no Hodgkin, linfoma Hodgkin adulto y pediátrico (Ann Arbor -Lugano) y mieloma múltiple. Registre:
1: Estadio I
2: Estadio II
3: Estadio III
4: Estadio IV
5: Estadio IA
6: Estadio IB
7: Estadio IIA
8: Estadio IIB
9: Estadio IIIA
10: Estadio IIIB
11: Estadio IVA
12: Estadio IVB
13: Extranodal cualquier estadio
14: Primario SNC
15: Primario Mediastinal
16: Primario de otros órganos
98: No Aplica (porque es un tumor diferente a los enunciados)
99: Desconocido, el dato de esta variable no se encuentra descrito en los soportes clínicos.

Aclaraciones
*Las opciones de respuesta con sufijos A y B contemplan la presencia o no de sintomatología sistémica, así mismo opciones de respuesta para compromiso extranodal de cualquier estadio, primarios en SNC, mediastinal o de otros órganos. Si sólo cuenta en los soportes con el estadio sin el sufijo, reportar la opción correspondiente de la 1 a la 4. *Si de identifica un estadiaje en la historia clínica que incluya una X, indica que se trata de un linfoma con formación de masa Bulky (mayor a 10cm); elegir el estadio que aplique haciendo caso omiso al sufijo X. *Para los usuarios con diagnóstico de cáncer a partir del 1 de noviembre de 2025 y que no alcanzaron a tener la consulta en donde se estadifica el tumor, reportar en esta variable la opción 99 y en la variable 128 la novedad 2, 10 o 13.

*Se incluye mieloma múltiple (MM) en el enunciado de la variable, para el reporte del estadiaje definido.

37. Para cáncer de próstata, valor de clasificación de la escala Gleason en el momento del diagnóstico: Registre la opción que corresponde a la clasificación Gleason.
11: Gleason ≤ 6: ≤ 3+3
12: Gleason 7: 3+4
13: Gleason 7: 4+3
14: Gleason 8: 4+4 o 3+5 o 5+3
15: Gleason 9 o 10: 4+5 o 5+4 o 5+5
97: Es cáncer de próstata, pero no hay información acerca de esta estadificación porque el diagnóstico fue clínico.
98: No es cáncer de próstata.
99: Es cáncer de próstata, pero no hay información en la historia clínica acerca de esta clasificación a pesar de que fue diagnóstico histopatológico.

Aclaraciones
*En los casos nuevos para el reporte la opción 99 se considera un dato no gestionado. *Las opciones de la 1 a la 10 no son válidas para pacientes reportados por primera vez a la CAC, independiente del año de diagnóstico; sólo se validan como parte del histórico a pacientes reportados antes del 2021.

38. Clasificación del riesgo leucemias, linfomas, mieloma múltiple (para toda la población) y sólidos pediátricos:

Clasificación de riesgo en linfoma no Hodgkin
Registre:
1: Bajo Riesgo
2: Riesgo intermedio bajo
3: Intermedio
4: Riesgo intermedio alto
5: Riesgo alto

Clasificación de riesgo en linfoma de Hodgkin
Registre:
1: Bajo Riesgo
5: Riesgo alto

Clasificación del riesgo en adultos (LLA, LMA y MM)
Registre:

1: Riesgo estándar, bajo
3: Riesgo intermedio
5: Riesgo alto

Clasificación del riesgo en Pediatría (LLA y LMA)
Registre:
1: Riesgo estándar, favorable, bajo riesgo.
3: Riesgo intermedio
5: Riesgo alto, desfavorable

98: No Aplica (no es leucemia, ni linfoma)
99: Desconocido, el dato de esta variable no se encuentra descrito en los soportes clínicos.

Aclaraciones
*Se mantienen las opciones de respuesta 1 a la 5, pero clasificadas por tipo de cáncer (leucemias y linfomas), basados en los sistemas de clasificación disponibles para cada uno de ellos. *Las opciones 6 a la 13 sólo son válidos para pacientes reportados antes del 2021, haciendo parte del histórico. *Para los usuarios con diagnóstico de cáncer a partir del 1 de noviembre de 2025 y que no alcanzaron a tener la consulta en donde se realiza la clasificación del riesgo, reportar en esta variable la opción 99 y en la variable 128 la novedad 2, 10 o 13. *Para los pacientes con linfoma de Hodgkin (LH), la homologación del estadio debe estar basada en los diferentes sistemas de clasificación (ejemplo: Hasenclever), en cuyo caso, si el estadio (variable 36) es I o II, el riesgo (variable 38) debe ser 1: Bajo riesgo y si el estadio es III o IV, la opción correcta es 2: Riesgo alto. *Se incluye mieloma múltiple (MM) en el enunciado de la variable, se debe reportar si el riesgo definido es bajo, intermedio o alto (1, 3 o 5). * Los siguientes cánceres no tienen clasificación de riesgo, por lo cual deben reportar la opción 98 no aplica.

39. Fecha de clasificación de riesgo: Registre la fecha en el formato AAAA-MM-DD. Si conoce sólo el año y el mes, registre el día 15.

Registre 1800-01-01: Desconocido, el dato de esta variable no se encuentra descrito en los soportes clínicos.
Registre 1845-01-01: No Aplica (no es leucemia, ni linfoma)

Aclaraciones
*Para los usuarios con diagnóstico de cáncer a partir del 1 de noviembre de 2025 y que no alcanzaron a tener la consulta en donde se realiza la clasificación del riesgo, reportar en esta variable la opción 1800-01-01 y en la variable 128 la novedad 2, 10 ó 13.

40. Objetivo (o intención) del tratamiento médico inicial (al diagnóstico) Registre:
1: Curación
2: Paliación (intención paliativa) exclusivamente.
3: Manejo expectante una vez se ha realizado el diagnóstico.
99: Desconocido, el dato de esta variable no se encuentra descrito en los soportes clínicos.

Aclaraciones
*La información de la variable corresponde a la decisión al momento del diagnóstico, esta no es modificable en el tiempo.

41. intervención médica durante el periodo de reporte, registre:

1: Observación previa a tratamiento (manejo expectante o casos en los que ya tienen orden médica de tratamiento, pero no alcanzó a ser administrado, dado que está cercano a la fecha del corte)
2: Ofrecer tratamiento curativo (quimioterapia, hormonoterapia, radioterapia, cirugía, terapia biológica) o paliativo dirigido al cáncer inicial o por recaída
3: Observación o seguimiento oncológico luego de tratamiento inicial (incluye tratamientos médicos para enfermedad general -no oncológica- y métodos diagnósticos de seguimiento)
4: 1 y 2 únicamente
5: 2 y 3 únicamente
6: 1, 2 y 3
99: No hay intervención en el periodo (abandono de terapia, alta oncológica ó alta voluntaria)

ANTECEDENTES AL DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER REPORTADO

42. Tiene antecedente o padece de otro cáncer primario (es decir, tiene o tuvo otro tumor maligno diferente al que está notificando): Registre:
1: Sí
2: No
99: Desconocido, el dato de esta variable no se encuentra descrito en los soportes clínicos.

Aclaraciones
*Si el paciente tiene 2 cánceres primarios del mismo agrupador, se debe capturar la información del segundo primario en variables 42 a 44 (ejemplo: mama bilateral, igual información en variables 17 y 44). *El segundo primario que se reporte, debe estar soportado en la historia clínica. *En caso de 2 cánceres primarios, tratándose de un caso nuevo, necesariamente debe estar reportado en 2 líneas, cada uno con el primario que corresponda en variable 17, y en la variable 44, reportar el segundo primario. *En los casos en que el paciente tiene 3 cáncer primarios, en el antecedente se debe reportar el más cercano a la fecha de corte. *La opción 99 aplica para historias clínicas que no permitan descartar o confirmar un segundo tipo de cáncer, o que lo mencionen, pero sus datos son insuficientes.

43. Fecha de diagnóstico del otro cáncer primario: Fecha en que se diagnosticó el otro cáncer primario que afecta al usuario en el formato AAAA-MM-DD. Si conoce sólo el año y el mes, registre el día 15.

Registre 1800-01-01: Desconocido, el dato de esta variable no se encuentra descrito en los soportes clínicos.
Registre 1845-01-01: No Aplica (no ha tenido otro cáncer primario)

44. Tipo (CIE-10) de ese cáncer antecedente o concurrente: Registre la enfermedad maligna antecedente o concurrente. Tenga en cuenta que antes de definir, por ejemplo, un linfoma, el usuario pudo tener un diagnóstico de cáncer a estudio o tumor de células pequeñas, redondas y azules, debe notificarse el linfoma. Registre el código de la enfermedad maligna diagnosticada al usuario según código CIE -10 (archivo operativo disponible en la plataforma SISCAC).

99: No Aplica (no hay antecedente o concurrencia de otro cáncer primario)

A continuación, las variables relacionadas con la estrategia terapéutica que recibió el paciente entre el 2 de enero de 2025 al 1 enero de 2026. Tener en cuenta que los pacientes que recibieron atención por entidades el régimen especial y EPS, cada entidad reporta el tratamiento que administró. Cuando el paciente presente dos o más primarios de cáncer, cada tratamiento se registra para el tipo de cáncer que corresponda, por ejemplo, histerectomía para cáncer de cérvix y esquema AC en cáncer de mama)

INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE TERAPIA SISTÉMICA E INTRATECAL EN EL PERIODO DE REPORTE ACTUAL

45. ¿Recibió el usuario quimioterapia u otra terapia sistémica (incluye quimioterapia, hormonoterapia, inmunoterapia y terapia dirigida) dentro del periodo de reporte?
Registre:
1: Sí recibió
98: No Aplica (no está indicada esta terapia, verifique que en las variables 46 a 73 se registra No Aplica)

Aclaraciones
*Cuando el paciente tiene dos o más cánceres primarios registre la terapia sistémica que está recibiendo el paciente como tratamiento para el cáncer reportado en la variable 17 o la metástasis de este. *Si el paciente tiene más de un cáncer primario, asegurarse de reportar la terapia que corresponde a cada una de las líneas del tipo de cáncer. *Sólo aplican tratamientos suministrados dentro del periodo de reporte, por lo cual los tratamientos orales deben estar soportados en una historia clínica de control y seguimiento, o en una fórmula de dispensación. *No aplican tratamientos oncológicos propuestos, pero no administrados.

46. ¿Cuántas fases de quimioterapia recibió el usuario en este periodo de reporte? (aplica para hematolinfáticos con los siguientes códigos de clasificación diagnóstica CIE-10; C835 Linfoma no Hodgkin linfoblástico (difuso), C910 Leucemia linfoblástica aguda, C920 Leucemia mieloide aguda, C924 Leucemia promielocìtica aguda y C925 Leucemia mielomonocítica aguda): Escriba el número de fases de quimioterapia propuestas para este periodo.

0: Es cáncer hematolinfático con los siguientes códigos de clasificación diagnóstica CIE 10 C835, C910, C920, C924 y C925) y en la variable 45 respondió la opción 98
98: No Aplica (es sólido o es cáncer diferente a los enunciados en las fases)

46.1. El usuario recibió en este periodo la fase de quimioterapia denominada Prefase o Citorreducción inicial (aplica solo para leucemia linfoide aguda y linfoma linfoblástico, puede haber recibido más de una fase): Registre:
1: Sí recibió
2: No recibió (aplica únicamente para los CIE 10 C835, C910, C920, C924 y C925)
97: No Aplica (no es **leucemia linfoide o mieloide aguda ni linfoma linfoblástico**)

46.2. El usuario recibió en este periodo la fase de quimioterapia denominada Inducción (aplica solo para leucemia linfoide o mieloide aguda y linfoma linfoblástico, puede haber recibido más de una fase): Registre:

1: Sí recibió
2: No recibió (aplica únicamente para los CIE 10 C835, C910, C920, C924 y C925)
97: No Aplica (no es **leucemia linfoide o mieloide aguda ni linfoma linfoblástico**)

46.3. El usuario recibió en este periodo la fase de quimioterapia denominada Intensificación (aplica solo para leucemia linfoide o mieloide aguda y linfoma linfoblástico, puede haber recibido más de una fase): Registre:
1: Sí recibió
2: No recibió (aplica únicamente para los CIE 10 C835, C910, C920, C924 y C925)
97: No Aplica (no es **leucemia linfoide o mieloide aguda ni linfoma linfoblástico**)

46.4. El usuario recibió en este periodo la fase de quimioterapia denominada Consolidación (aplica solo para leucemia linfoide o mieloide aguda y linfoma linfoblástico, puede haber recibido más de una fase): Registre:
1: Sí recibió
2: No recibió (aplica únicamente para los CIE 10 C835, C910, C920, C924 y C925)
97: No Aplica (no es **leucemia linfoide o mieloide aguda ni linfoma linfoblástico**)

46.5. El usuario recibió en este periodo la fase de quimioterapia denominada Reinducción (aplica solo para leucemia linfoide aguda y linfoma linfoblástico, puede haber recibido más de una fase): Registre:
1: Sí recibió
2: No recibió (aplica únicamente para los CIE 10 C835, C910, C920, C924 y C925)
97: No Aplica (no es leucemia linfoide aguda ni linfoma linfoblástico)

46.6. El usuario recibió en este periodo la fase de quimioterapia denominada Mantenimiento (aplica solo para leucemia linfoide o mieloide aguda y linfoma linfoblástico, puede haber recibido más de una fase): Registre:
1: Sí recibió
2: No recibió (aplica únicamente para los CIE 10 C835, C910, C920, C924 y C925)
97: No Aplica (no es **leucemia linfoide o mieloide aguda ni linfoma linfoblástico**)

46.7. El usuario recibió en este periodo la fase de quimioterapia denominada Mantenimiento largo o final (aplica solo para leucemia linfoide o mieloide aguda y linfoma linfoblástico, puede haber recibido más de una fase): Registre:

1: Sí recibió
2: No recibió (aplica únicamente para los CIE 10 C835, C910, C920, C924 y C925)
97: No Aplica (no es **leucemia linfoide o mieloide aguda ni linfoma linfoblástico**)

46.8. El usuario recibió en este periodo Otra fase de quimioterapia denominada diferente a las anteriores (aplica solo para leucemia linfoide o mieloide aguda y linfoma linfoblástico, puede haber recibido más de una fase): Registre:

1: Sí recibió
2: No recibió (aplica únicamente para los CIE 10 C835, C910, C920, C924 y C925)
97: No Aplica (no es **leucemia linfoide o mieloide aguda ni linfoma linfoblástico**)

47. Número de ciclos iniciados y administrados en el periodo de reporte, incluyendo el que aún recibe en la fecha de finalización del periodo (aplica para todos los cánceres): Escriba el número de ciclos iniciados en el periodo de reporte actual (pueden ser ciclos en diferentes esquemas de manejo)

98: No Aplica o no la recibió, aunque fue formulada (en la variable 45 seleccionó 98)

Aclaraciones
*Ciclos: el número de administraciones del esquema o protocolo según el plan terapéutico indicado por el especialista tratante. *En el manejo de los tumores sólidos los ciclos generalmente tienen periodo de descanso entre una y otra administración del esquema, registre de acuerdo con la historia clínica. *Para los cánceres hematolinfáticos registrar según la descripción en la historia clínica, ya que el ciclo se define por el protocolo que recibe el paciente. *Para las hormonoterapias el dato en esta variable es 1 (un ciclo) en tratamientos orales sin periodos de descanso. *Para las terapias hormonales vía intramuscular o subcutánea se cuenta el número de aplicaciones del periodo, cada aplicación es un ciclo. *Cada administración de medicamentos vía intratecal, debe ser contada como un ciclo

48. Ubicación temporal del primer o único esquema de quimioterapia o terapia sistémica en el periodo en relación al manejo oncológico: Registre:
1: Neoadyuvancia (manejo inicial prequirúrgico)
2: Tratamiento inicial curativo sin cirugía sugerida (por ejemplo, sería una opción frecuente en caso de leucemias o linfomas, u otros cánceres a quienes no se les hizo cirugía)
3: Adyuvancia (manejo inicial postquirúrgico)
11: Manejo de recaída
12: Manejo de enfermedad metastásica
13: Manejo paliativo (sin manejo de recaída ni enfermedad metastásica)
98: No Aplica (en la variable 45 seleccionó la opción 98)

Aclaraciones

*Esquema o protocolo es el plan terapéutico de la terapia sistémica para el manejo curativo del cáncer, este puede ser uno o varios medicamentos que se administran en un mismo tiempo o en diferente tiempo según lo defina el profesional tratante basado en guías y protocolos médicos. *En los casos de hormonoterapia para cáncer de mama que generalmente se administra por periodos de tiempo de 5 hasta 10 años, si éste comenzó posterior a cirugía, la opción de respuesta es adyuvancia.

49. Fecha de inicio del primer o único esquema de quimioterapia o terapia sistémica que recibió en este periodo. Este esquema pudo haber sido iniciado antes de periodo de reporte. Registre esta fecha en que se inició este esquema de quimioterapia en el formato AAAA-MM-DD. Si conoce sólo el año y el mes, registre el día 15.

Registre 1845-01-01: No Aplica (en la variable 45 seleccionó la opción 98).

Aclaraciones
*Es común que el paciente reciba esquemas prolongados, por tanto, es válido que la fecha a registrar en esta variable anteceda al periodo y se continúe suministrando en el periodo actual. *La información a registrar corresponde a la fecha de inicio efectivo del medicamento, mas no a la fecha de prescripción de este.

50. Número de IPS que suministran el primer o único esquema de quimioterapia o terapia sistémica de este periodo de reporte: Registre el número de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud que suministran el primer esquema de quimioterapia del periodo de reporte.

98: No aplica (en la variable 45 seleccionó la opción 98)

51. Código de la IPS1 que suministra el primer o único esquema de quimioterapia o terapia sistémica de este periodo de reporte: registre el código de habilitación de IPS (disponible en la página web REPS – código de 12 dígitos incluido el cero inicial). Para todos los tratamientos orales, se debe consignar el código de habilitación de la IPS que le prescribió el tratamiento no el código del operador logístico que realiza la entrega.

96: Terapia sistémica suministrada fuera del país
98: No Aplica (en la variable 45 seleccionó la opción 98)

52. Código de la IPS2 que suministra el primer o único esquema de quimioterapia o terapia sistémica de este periodo de reporte: registre el código de habilitación de IPS (disponible en la página web REPS – código de 12 dígitos incluido el cero inicial)

98: No Aplica

Aclaraciones
*Verifique que la IPS cuente con el servicio de quimioterapia habilitado de acuerdo con el REPS *Para todos los tratamientos orales, se debe consignar el código de habilitación de la IPS que le prescribió el tratamiento no el código del operador logístico que realiza la entrega. *Se incluye en variable 51, la opción de terapia sistémica suministrada fuera del país, para pacientes con diagnóstico confirmado en Colombia o que actualmente residan en el país, quienes reciben al menos parte del esquema por un prestador extranjero.

53. Cuantos medicamentos antineoplásicos o terapia hormonal, el (los) especialista(s) tratante(s) del cáncer propusieron como manejo en el primer o único esquema de quimioterapia o terapia sistémica de este periodo de reporte: Escriba el número de medicamentos antineoplásicos propuestos en el primer esquema de este periodo. Recuerde descontar el número de medicamento adyuvantes o de premedicación de la terapia que no son antineoplásicos.

98: No Aplica (en la variable 45 seleccionó la opción 98)

Aclaraciones
*Registrar el número total de medicamentos propuestos (no necesariamente administrados) durante el periodo, por el o los especialistas tratantes. *En las variables 53.1 a 53.9 y 54 a 56, registre los ATC sólo de los fármacos administrados en el periodo. *Los ATC correspondientes a esteroides (dexametasona, prednisolona, prednisona y metilprednisolona), no deben ser reportados en pacientes con cánceres sólidos, linfomas de Hodgkin ni con leucemia mieloide aguda, ya que su utilidad en este tipo de pacientes no está dada en efecto antineoplásico sino reducción de efectos adversos. *Todo paciente con cáncer sólido o hematolinfático que reciba pegfilgastrim como parte de su esquema de tratamiento, debe ser reportado más no cuantificado. No es válido como monoterapia (único fármaco). *Los fármacos antirresortivos (ácido ibandrónico, alendronato, zoledrónico y denosumab), sólo se consideran válidos para la cohorte, si su indicación corresponde a manejo de metástasis ósea, incluyendo hipercalcemia maligna. ***Debe ser reportado más no cuantificado.***

53.1. Medicamento antineoplásico administrado al usuario- PRIMER o único esquema del periodo de reporte. Registre el código ATC del medicamento (Incluido o no en el plan de beneficios)
98: No aplica, en la variable 45 seleccionó la opción 98

53.2. Medicamento antineoplásico administrado al usuario- PRIMER o único esquema del periodo de reporte. Registre el código ATC del medicamento (Incluido o no en el plan de beneficios)
97: Sí recibió quimioterapia, ya registrada en las variables anteriores (en la variable 45 seleccionó la opción 1)
98: No aplica, en la variable 45 seleccionó la opción 98

53.3. Medicamento antineoplásico administrado al usuario- PRIMER o único esquema del periodo de reporte. Registre el código ATC del medicamento (Incluido o no en el plan de beneficios)
97: Sí recibió quimioterapia, ya registrada en las variables anteriores (en la variable 45 seleccionó la opción 1)
98: No aplica, en la variable 45 seleccionó la opción 98

53.4. Medicamento antineoplásico administrado al usuario- PRIMER o único esquema del periodo de reporte. Registre el código ATC del medicamento (Incluido o no en el plan de beneficios)
97: Sí recibió quimioterapia, ya registrada en las variables anteriores (en la variable 45 seleccionó la opción 1)
98: No aplica, en la variable 45 seleccionó la opción 98

53.5. Medicamento antineoplásico administrado al usuario- PRIMER o único esquema del periodo de reporte. Registre el código ATC del medicamento (Incluido o no en el plan de beneficios)
97: Sí recibió quimioterapia, ya registrada en las variables anteriores (en la variable 45 seleccionó la opción 1)
98: No aplica, en la variable 45 seleccionó la opción 98

53.6. Medicamento antineoplásico administrado al usuario- PRIMER o único esquema del periodo de reporte. Registre el código ATC del medicamento (Incluido o no en el plan de beneficios)
97: Sí recibió quimioterapia, ya registrada en las variables anteriores (en la variable 45 seleccionó la opción 1)
98: No aplica, en la variable 45 seleccionó la opción 98

53.7. Medicamento antineoplásico administrado al usuario- PRIMER o único esquema del periodo de reporte. Registre el código ATC del medicamento (Incluido o no en el plan de beneficios)
97: Sí recibió quimioterapia, ya registrada en las variables anteriores (en la variable 45 seleccionó la opción 1)
98: No aplica, en la variable 45 seleccionó la opción 98

53.8. Medicamento antineoplásico administrado al usuario- PRIMER o único esquema del periodo de reporte. Registre el código ATC del medicamento (Incluido o no en el plan de beneficios)
97: Sí recibió quimioterapia, ya registrada en las variables anteriores (en la variable 45 seleccionó la opción 1)
98: No aplica, en la variable 45 seleccionó la opción 98

53.9. Medicamento antineoplásico administrado al usuario- PRIMER o único esquema del periodo de reporte. Registre el código ATC del medicamento (Incluido o no en el plan de beneficios)
97: Sí recibió quimioterapia, ya registrada en las variables anteriores (en la variable 45 seleccionó la opción 1)
98: No aplica, en la variable 45 seleccionó la opción 98

Aclaraciones variables 53.1 a 53.9
*Verifique que los ATC registrados en las variables se encuentre descritos en los soportes clínico y hayan sido administrados entre el 2 enero de 2025 al 1 enero de 2026. *No debe capturar el mismo esquema de tratamiento en primer y segundo o último esquema

54. Medicamento Antineoplásico o terapia hormonal para el cáncer, adicional a los reportados en las variables 53.1 a 53.9 - 1 administrado al usuario- primer o único esquema del periodo de reporte: Registre el código ATC del medicamento (no se tiene presente la cobertura del plan de beneficios en salud) del listado usado en este caso (disponible en la plataforma SISCAC)

97: No Aplica (No recibió medicamentos diferentes a los enunciados en las variables 53.1 a la 53.9 y en la variable 45 seleccionó la opción 1)
98: No Aplica (no tuvo este esquema y en la variable 45 seleccionó la opción 98)

Aclaraciones
*Verifique que el medicamento no se encuentre en el listado de la variable 53.1 a 53.9 *Reporte únicamente medicamentos antineoplásicos *Recuerde que, al reportar antineoplásicos en esta variable, debe revisar que no se repitan en variables 55 y 56 *No debe capturar el mismo esquema de tratamiento en primer y segundo esquema

55. Medicamento Antineoplásico o terapia hormonal para el cáncer, adicional a los reportados en las variables 53.1 a 53.9 - 2 administrado al usuario- primer o único esquema del periodo de reporte: Registre el código ATC del medicamento (no se tiene presente la cobertura del plan de beneficios en salud) listado usado en este caso (disponible en la plataforma SISCAC).

97: No Aplica (No recibió medicamento diferente a los enunciados en las variables 53.1 a la 53.9 y en la variable 45 seleccionó la opción 1)
98: No Aplica (no tuvo este esquema y en la variable 45 seleccionó la opción 98)

Aclaraciones
*Verifique que el medicamento no se encuentre en el listado de la variable 53.1 a 53.9 *Reporte únicamente medicamentos antineoplásicos

56. Medicamento Antineoplásico o terapia hormonal para el cáncer, adicional a los reportados en las variables 53.1 a 53.9 - 3 administrado al usuario- primer o único esquema del periodo de reporte: Registre el código ATC del medicamento (no se tiene presente la cobertura del plan de beneficios en salud) listado usado en este caso (disponible en la plataforma SISCAC).

97: No Aplica (No recibió medicamento diferente a los enunciados en las variables 53.1 a la 53.9 y en la variable 45 seleccionó la opción 1)
98: No Aplica (no tuvo este esquema y en la variable 45 seleccionó la opción 98)

Aclaraciones
*Verifique que el medicamento no se encuentre en el listado de la variable 53.1 a 53.9 *Reporte únicamente medicamentos antineoplásicos

57. ¿Recibió quimioterapia intratecal en el primer o único esquema de este periodo de reporte?: Registre:
1: Sí recibió
2: No recibió
98: No Aplica (no tuvo ningún esquema de quimioterapia, en variable 45 seleccionó 98: No aplica)

Aclaraciones
*Si el paciente tiene un cáncer en el que no aplica la quimioterapia intratecal y recibió un tratamiento de quimioterapia o terapia sistémica por favor registre la opción 2:no recibió.

58. Fecha de finalización del primer o único esquema de este periodo de reporte. Si es hormonoterapia terminada o esquema terminado en este periodo reporte la fecha de finalización del tratamiento actual: Fecha en que terminó la administración del primer o único esquema de quimioterapia en el formato AAAA-MM-DD. Si conoce sólo el año y el mes, registre el día 15.

Registre 1845-01-01: No Aplica (en la variable 45 seleccionó la opción 98).
Registre 1800-01-01: para casos de hormonoterapia o de esquema que aún no finalizan.

59. Características actuales del primer o único esquema de este periodo de reporte:
1: Finalizado, esquema completo según medicamentos programados
2: Finalizado, esquema incompleto pero finalizado por algún motivo
3: No finalizado, esquema incompleto, pero aún bajo tratamiento (ejemplo: hormonoterapia o esquema no finalizado)
98: No Aplica (no tuvo ningún esquema de terapia sistémica y en la variable 45 seleccionó la opción 98)

60. Motivo de la finalización (prematura) de este primer o único esquema (Aplica si registró la opción 2 de la variable anterior). Seleccione un sólo número (lo que primero ocurrió): Registre:
1: Toxicidad de uno o más medicamentos
2: Otros motivos médicos
3: Muerte
4: Cambio de EAPB
5: Decisión del usuario, abandonó la terapia
6: No hay disponibilidad de medicamentos
7: Otros motivos administrativos
8: Otras causas no contempladas
98: No Aplica

61. Ubicación temporal del <u>ÚLTIMO</u> esquema de quimioterapia o terapia sistémica de este periodo de reporte en relación con el manejo oncológico: (Si en el periodo recibió únicamente hormonoterapia no reportar nuevamente en esquema final), Registre:
Registre:
1: Neoadyuvancia (manejo inicial prequirúrgico)
2: Tratamiento inicial curativo sin cirugía sugerida (por ejemplo, sería una opción frecuente en caso de leucemias o linfomas, u otros cánceres a quienes no se les hizo cirugía)
3: Adyuvancia (manejo inicial postquirúrgico)
11: Manejo de progresión o recaída
12: Manejo de enfermedad metastásica
13: Cambio por toxicidad
14: Manejo paliativo (sin manejo de recaída ni enfermedad metastásica)
97: Solo recibió un esquema de quimioterapia en este periodo y en la variable 45 seleccionó la opción 1. (verifique que las variables 62 a 73 registren No Aplica)
98: No Aplica (en la variable 45 seleccionó la opción 98)

Aclaraciones
*Para pacientes que recibieron un solo esquema dentro del periodo de reporte y aún no finalizan, por favor registre la opción 97. *No debe capturar el mismo esquema de tratamiento de las variables 45 a 61 en las 62 a 73.

62. Fecha de inicio del último esquema de quimioterapia o terapia sistémica de este periodo de reporte. Si es hormonoterapia reporte la fecha de inicio del tratamiento actual, así haya sido iniciada previo al reporte actual: Fecha en que se inició este esquema de quimioterapia en el formato AAAA-MM-DD. Si conoce sólo el año y el mes, registre el día 15.
Registre 1845-01-01: No Aplica.

63. Número de IPS que suministran el último esquema de este periodo de reporte: Registre el número de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud que suministran el último esquema de quimioterapia
98: No aplica

64. Código de la IPS1 que suministra el último esquema en este periodo de reporte: registre el código de habilitación de IPS (disponible en la página web REPS – código de 12 dígitos incluido el cero inicial). Para todos los tratamientos orales, se debe consignar el código de habilitación de la IPS que le prescribió el tratamiento, no el código del operador logístico que realiza la entrega.
98: No Aplica

65. Código de la IPS2 que suministra el último esquema en este periodo de reporte: registre el código de habilitación de IPS (disponible en la página web REPS – código de 12 dígitos incluido el cero inicial). Para todos los tratamientos orales, se debe consignar el código de habilitación de la IPS que le prescribió el tratamiento no el código del operador logístico que realiza la entrega.
98: No Aplica.

66. Cuantos medicamentos antineoplásicos o terapia hormonal, el (los) especialista(s) tratante(s) del cáncer propusieron como manejo en ÚLTIMO esquema de quimioterapia o terapia sistémica de este periodo de reporte: Escriba el número de medicamentos antineoplásicos propuestos en el primer esquema de este periodo. Recuerde descontar el número de medicamento adyuvantes o de premedicación de la terapia que no son antineoplásicos.
98: No Aplica, no recibió segundo esquema o en la 45 marcó opción 98

Aclaraciones
*Registrar el número total de medicamentos propuestos (no necesariamente administrados) durante el periodo, por el o los especialistas tratantes. *En las variables 66.1 a 66.9 y 67 a 69, registre los ATC sólo de los fármacos administrados en el periodo

66.1. Medicamento antineoplásico administrado al usuario- ÚLTIMO esquema del periodo de reporte. Registre el código ATC del medicamento (Incluido o no en el plan de beneficios)
98: No aplica

66.2. Medicamento antineoplásico administrado al usuario- ÚLTIMO esquema del periodo de reporte. Registre el código ATC del medicamento (Incluido o no en el plan de beneficios)
97: Sí recibió quimioterapia, ya registrada en las variables anteriores (en la variable 45 seleccionó la opción 1)
98: No aplica

66.3. Medicamento antineoplásico administrado al usuario- ÚLTIMO esquema del periodo de reporte. Registre el código ATC del medicamento (Incluido o no en el plan de beneficios)
97: Sí recibió quimioterapia, ya registrada en las variables anteriores (en la variable 45 seleccionó la opción 1)
98: No aplica

66.4. Medicamento antineoplásico administrado al usuario- ÚLTIMO esquema del periodo de reporte. Registre el código ATC del medicamento (Incluido o no en el plan de beneficios)
97: Sí recibió quimioterapia, ya registrada en las variables anteriores (en la variable 45 seleccionó la opción 1)
98: No aplica

66.5. Medicamento antineoplásico administrado al usuario- ÚLTIMO esquema del periodo de reporte. Registre el código ATC del medicamento (Incluido o no en el plan de beneficios)

97: Sí recibió quimioterapia, ya registrada en las variables anteriores (en la variable 45 seleccionó la opción 1)
98: No aplica

66.6. Medicamento antineoplásico administrado al usuario- ÚLTIMO esquema del periodo de reporte. Registre el código ATC del medicamento (Incluido o no en el plan de beneficios)
97: Sí recibió quimioterapia, ya registrada en las variables anteriores (en la variable 45 seleccionó la opción 1)
98: No aplica

66.7. Medicamento antineoplásico administrado al usuario- ÚLTIMO esquema del periodo de reporte. Registre el código ATC del medicamento (Incluido o no en el plan de beneficios)

97: Sí recibió quimioterapia, ya registrada en las variables anteriores (en la variable 45 seleccionó la opción 1)
98: No aplica

66.8. Medicamento antineoplásico administrado al usuario- ÚLTIMO esquema del periodo de reporte. Registre el código ATC del medicamento (Incluido o no en el plan de beneficios)
97: Sí recibió quimioterapia, ya registrada en las variables anteriores (en la variable 45 seleccionó la opción 1)
98: No aplica

66.9. Medicamento antineoplásico administrado al usuario- ÚLTIMO esquema del periodo de reporte. Registre el código ATC del medicamento (Incluido o no en el plan de beneficios)

97: Sí recibió quimioterapia, ya registrada en las variables anteriores (en la variable 45 seleccionó la opción 1)
98: No aplica

67. Medicamento Antineoplásico o terapia hormonal para cáncer, adicional a los reportados en variables 66.1 a 66.9 -1 administrado al usuario- último esquema: Registre el código ATC del medicamento (no se tiene presente la cobertura del Plan de Beneficios en Salud)

97: No Aplica (No recibió medicamento diferente a los enunciados en las variables 66.1 a la 66.9 y en la variable 61 seleccionó una opción <:14)
98: No Aplica (no tuvo este último esquema o en la variable 61 seleccionó la opción 97 ó 98)

Aclaraciones
*Verifique que el medicamento no se encuentre en el listado de la variable 66.1 a 66.9 *Reporte únicamente medicamentos antineoplásicos *Recuerde que, al reportar antineoplásicos en esta variable, debe revisar que no se repitan en variables 68 y 69

68. Medicamento Antineoplásico o terapia hormonal para cáncer, adicional a los reportados en variables 66.1 a 66.9 -2 administrado al usuario- último esquema: Registre el código ATC del medicamento independiente de la cobertura del Plan de Beneficios en Salud.

97: No Aplica (No recibió medicamento diferente a los enunciados en las variables 66.1 a la 66.9 en la variable 61 seleccionó una opción <:14)
98: No Aplica (no tuvo este último esquema o en la variable 61 seleccionó la opción 97 ó 98)

Aclaraciones
*Verifique que el medicamento no se encuentre en el listado de la variable 66.1 a 66.9 *Reporte únicamente medicamentos antineoplásicos

69. Medicamento Antineoplásico o terapia hormonal para cáncer, adicional a los reportados en variables 66.1 a 66.9 Registre el código ATC del medicamento independiente de la cobertura del Plan de Beneficios en Salud.
97: No Aplica (No recibió medicamento diferente a los enunciados en las variables 66.1 a la 66.9 y en la variable 61 seleccionó una opción <:14)
98: No Aplica (no tuvo este último esquema o en la variable 61 seleccionó la opción 97 o 98)

Aclaraciones
*Verifique que el medicamento no se encuentre en el listado de la variable 66.1 a 66.9 *Reporte únicamente medicamentos antineoplásicos

70. ¿Recibió quimioterapia intratecal en el último esquema de este periodo de reporte?:
Registre:
1: Si recibió
2: No recibió
98: No Aplica (no tuvo ningún esquema de quimioterapia, en variable 45 seleccionó 98: No aplica)

71. Fecha de finalización del último esquema de quimioterapia o terapia sistémica este periodo de reporte. Si es hormonoterapia o esquema terminados en este periodo reporte la fecha de finalización del tratamiento actual: Fecha en que terminó la administración del último esquema de quimioterapia en el formato AAAA-MM-DD. Si conoce sólo el año y el mes, registre el día 15.
Registre 1845-01-01: No Aplica.
Registre 1800-01-01: para casos de hormonoterapia o de esquema que aún no finalizan.

72. Características actuales del último esquema de este periodo:
Registre:
1: Finalizado, esquema completo según medicamentos programados
2: Finalizado, esquema incompleto pero finalizado por algún motivo
3: No finalizado, esquema incompleto, pero aún bajo tratamiento (ejemplo: hormonoterapia o esquema no finalizado)
98: No Aplica

73. Motivo de la finalización (prematura) de este último esquema (Aplica si registró la opción 2 de la pregunta anterior) Seleccione un sólo número (lo que primero ocurrió):
Registre:
1: Toxicidad de uno o más medicamentos
2: Otros motivos médicos
3: Muerte
4: Cambio de EPS
5: Decisión del usuario, abandonó la terapia
6: No hay disponibilidad de medicamentos

7: Otros motivos administrativos
8: Otras causas no contempladas
98: No Aplica

INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE CIRUGÍA EN EL PERIODO DE REPORTE ACTUAL

74. ¿Fue sometido el usuario a una o más cirugías curativas o paliativas como parte del manejo del cáncer durante este periodo de reporte?: Registre:
1: Si fue sometido al menos a una cirugía durante este periodo
2: No recibió cirugía

Aclaraciones
*Para los casos en que el procedimiento quirúrgico es diagnóstico y terapéutico (ejemplo: tiroidectomía o resección de tumores de piel) reporte el procedimiento en esta variable y registre la misma fecha de la variable 23. *Reporte los procedimientos a partir del listado CUPS del archivo operativo y verifique que el objetivo del procedimiento es tratamiento para el manejo del cáncer. *Cuando en cánceres hematolinfáticos tengan un procedimiento quirúrgico, verifique minuciosamente que corresponde al manejo del cáncer. *No son objeto de reporte la realización de implante de catéter, punción lumbar, biopsias ni cierre de ostomías (colostomía, ileostomía, gastrostomía, nefrostomía, traqueostomía, etc), se aclara, que los procedimientos a reportar son los indicados específicamente para el manejo del cáncer, y no sus complicaciones. *Si durante el mismo tiempo quirúrgico, el paciente recibió varias intervenciones que apliquen para el reporte, se debe seleccionar la más representativa en relación con el tipo de cáncer. *No aplican cirugías propuestas, pero no realizadas (se eliminó opción 3).

75. Número de cirugías a las que fue sometido el usuario durante el periodo de reporte actual: Registre el número de cirugías a las que el usuario fue sometido durante el periodo de reporte actual, incluya aquellas por complicaciones relacionadas a la cirugía inicial. Valide que se esté reportando la cantidad de cirugías (tiempos quirúrgicos) y no la cantidad de procedimientos CUPS realizados dentro de una o varias cirugías.
98: No Aplica (si respondió 2 en la pregunta anterior)

76. Fecha de realización de la primera cirugía en este periodo de reporte: Registre la fecha en el formato AAAA-MM-DD. Si conoce sólo el año y el mes, registre el día 15.
1845-01-01: No Aplica.

77. Código de la IPS que realizó la primera cirugía de este periodo de reporte: Registre el código de habilitación de la IPS (disponible en la página web REPS – código de 12 dígitos incluido el cero inicial)

96: Cirugía fuera del país
98: No Aplica

78. Código de primera cirugía en este periodo de reporte: Registre el código de procedimiento CUPS (disponible en la plataforma SISCAC) se recomienda utilizar el CUPS que tenga mayor relación con el manejo del cáncer o el que mayor complejidad represente dentro de la cirugía).
98: No Aplica (seleccionó la opción 2 en la variable 74)

Aclaraciones
*Los procedimientos como fotoféresis, fototerapia, crioterapia y radiofrecuencia, se deben reportar en esta variable, con el código CUP correspondiente; tener en cuenta en variable 74 y cuantificar en variable 75.

79. Ubicación temporal de esta primera cirugía en relación al manejo oncológico: Esta cirugía es:
1: Parte del manejo inicial para el cáncer (tratamiento inicial curativo)
5: Manejo de recaída
6: Manejo de enfermedad metastásica.
98: No Aplica (seleccionó la opción 2 en la variable 74).

80. Fecha de realización de la última cirugía o cirugía de reintervención en este periodo de reporte: Registre la Fecha de realización de la última cirugía en el formato AAAA-MM-DD. Si conoce sólo el año y el mes, registre el día 15.

1845-01-01: No Aplica (sólo hubo una intervención en este periodo o no hubo cirugías en este periodo).

Aclaraciones
*Valide que no se estén reportando datos del evento quirúrgico denominado como primera cirugía de este periodo.

81. Motivo de haber realizado la última cirugía de este periodo de reporte: Registre:
1: Complementar tratamiento quirúrgico del cáncer no asociado a complicaciones de la primera cirugía
2: Complicaciones debida a la primera cirugía o siguientes
3: Complicaciones por otras condiciones médicas no relacionadas a la cirugía (por ejemplo, comorbilidad)
5: 1 y 3
6: 2 y 3
98: No Aplica (sólo hubo una intervención en este periodo o no hubo cirugías en este periodo)

82. Código de la IPS que realiza la última cirugía en este periodo de reporte: registre el código de habilitación de IPS (disponible en la página web REPS – código de 12 dígitos incluido el cero inicial).
98: No Aplica (sólo hubo una intervención en este periodo o no hubo cirugías en este periodo)

83. Código de última cirugía en este periodo de reporte: Registre el código de procedimiento CUPS (archivo operativo CUPS en SISCAC). Se recomienda utilizar el CUPS que tenga mayor relación con el manejo del cáncer o el que mayor complejidad represente dentro de la cirugía.
98: No Aplica (sólo hubo una intervención en este periodo o no hubo cirugías en este periodo)

84. Ubicación temporal de esta <u>última</u> cirugía en relación al manejo oncológico, en este periodo de reporte:
Esta cirugía es:
1: Parte del manejo inicial para el cáncer (manejo inicial curativo)
5: Manejo de recaída.
6: Manejo de enfermedad metastásica.
98: No Aplica (sólo hubo una intervención en este periodo o seleccionó la opción 2 en la variable 74)

85. Estado vital al finalizar la única o última cirugía de este periodo de reporte:
Registre:
1: Vivo
2: Fallecido
98: No Aplica (seleccionó la opción 2 en la variable 74)

INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE RADIOTERAPIA EN EL PERIODO DE REPORTE ACTUAL

86. ¿Recibió el usuario algún tipo de radioterapia en el periodo de reporte actual?:
Registre:
1: Si recibió algún tipo de radioterapia
98: No aplica (verifique que en las variables 87 a 105 se registre no Aplica)

Aclaraciones
*No aplica radioterapia propuesta más no suministrada (se eliminó la opción 2)

87. Número de sesiones de radioterapia recibidas en el periodo. Registre el número de sesiones de radioterapia suministrados durante el periodo de reporte actual (valide que en los soportes

exista la cantidad de sesiones ordenadas que serán capturadas en el momento de la auditoria en variable adicional). Registre un valor numérico.
98: No Aplica

Aclaraciones
*Registre el número total de sesiones de radioterapia interna o externa, suministradas en el periodo.

88. Fecha de inicio de primer o único esquema de cualquier tipo de radioterapia suministrado en el periodo de reporte actual. Reporte la fecha de inicio del tratamiento actual, así haya sido iniciada previo al reporte actual: Registre la fecha en que se inició cualquiera de los tipos de radioterapia en el formato AAAA-MM-DD. Si conoce sólo el año y el mes, registre el día 15.
1845-01-01: No Aplica.

89. Ubicación temporal del primer o único esquema de cualquier tipo de radioterapia en este periodo de reporte en relación al tratamiento oncológico: Registre para todos los usuarios:

1: Neoadyuvancia (manejo inicial prequirúrgico)
2: Tratamiento inicial curativo sin cirugía sugerida (por ejemplo, solo algunos cánceres que se curan con radioterapia exclusiva)
3: Adyuvancia (manejo inicial postquirúrgico)
11: Manejo de recaída
12: Manejo de enfermedad metastásica
13: Manejo paliativo (sin manejo de recaída ni enfermedad metastásica)
98: No Aplica

90. Tipo de radioterapia aplicada en este primer o único esquema: Registre el código de procedimiento CUPS (archivo operativo CAC)
98: No Aplica

91. Número de IPS que suministran este primer o único esquema de radioterapia: Registre el número de IPS que intervinieron en la administración de la dosis de radioterapia.
98: No Aplica

92. Código de la IPS1 que suministra la radioterapia de este primer o único esquema: registre el código de habilitación de IPS (disponible en la página web REPS – código de 12 dígitos incluido el cero inicial)
96: Radioterapia fuera del país
98: No Aplica

93. Código de la IPS2 que suministra la radioterapia de este primer o único esquema: registre el código de habilitación de IPS (disponible en la página web REPS – código de 12 dígitos incluido el cero inicial)
98: No Aplica

94. Fecha de finalización de primer o único esquema de radioterapia: Registre la fecha de finalización de cualquiera de los tipos de radioterapia en el formato AAAA-MM-DD. Si conoce sólo el año y el mes, registre el día 15.
1800-01-01: esquema de radioterapia que aún no finalizan.
1845-01-01: No Aplica.

95. Características actuales de este primer o único esquema de radioterapia: Registre:
1: Finalizado, dosis completa de radioterapia prescrita
2: Finalizado, dosis incompleta pero finalizada por algún motivo
3: No finalizado, esquema incompleto, pero aún bajo tratamiento
98: No Aplica

96. Motivo de la finalización de este primer o único esquema de radioterapia (aplica si registró la opción 2 de la pregunta anterior). Seleccione un sólo número (lo que primero ocurrió): Registre:
1: Toxicidad
2: Otros motivos médicos
3: Muerte
4: Cambio de EPS
5: Decisión del usuario, abandono la terapia.
6: Otros motivos administrativos
7: Otras causas no contempladas
98: No Aplica

97. Fecha de inicio del último esquema de cualquier tipo de radioterapia suministrado en el periodo de reporte actual: Registre la fecha en que se inició el último esquema, de cualquiera de los tipos de radioterapia en el formato AAAA-MM-DD. Si conoce sólo el año y el mes, registre el día 15.
1845-01-01: No Aplica.

98. Ubicación temporal/intención del ÚLTIMO esquema de cualquier tipo de radioterapia suministrado en el periodo actual en relación al tratamiento oncológico: Registre:

1: Neoadyuvancia (manejo inicial prequirúrgico)
2: Tratamiento inicial curativo sin cirugía sugerida (por ejemplo, Solo algunos cánceres que se curan con radioterapia exclusiva)
3: Adyuvancia (manejo inicial postquirúrgico)
11: Manejo de recaída
12: Manejo de enfermedad metastásica
13: Manejo paliativo (sin manejo de recaída ni enfermedad metastásica)

98: No aplica

99. Tipo de radioterapia aplicada en el ÚLTIMO esquema de cualquier tipo de radioterapia suministrado en el periodo de reporte actual: Registre el código de procedimiento CUPS (archivo operativo CAC)
98: No Aplica

100. Número de IPS que suministran este último esquema de cualquier tipo de radioterapia en el periodo de reporte actual: Registre el número de IPS que intervinieron en la administración de la dosis de radioterapia
98: No Aplica

101. Código de la IPS1 que suministra último esquema de cualquier tipo de radioterapia en el periodo de reporte actual: registre el código de habilitación de IPS (disponible en la página web REPS – código de 12 dígitos incluido el cero inicial).
98: No Aplica

102. Código de la IPS2 que suministra último esquema de cualquier tipo de radioterapia en el periodo de reporte actual: registre el código de habilitación de IPS (disponible en la página web REPS – código de 12 dígitos incluido el cero inicial).
98: No Aplica

103. Fecha de finalización del último esquema de cualquier tipo de radioterapia suministrado en el periodo de reporte actual: Registre la Fecha de finalización de cualquiera de los tipos de radioterapia en el formato AAAA-MM-DD. Si conoce sólo el año y el mes, registre el día 15.

Registre 1800-01-01: para esquemas de radioterapia que aún no finalizan
Registre 1845-01-01: No Aplica.

104. Características actuales de este último esquema de cualquier tipo de radioterapia suministrado en el periodo de reporte actual: Registre:
1: Finalizado, dosis completa de radioterapia prescrita
2: Finalizado, dosis incompleta pero finalizada por algún motivo
3: No finalizado, esquema incompleto, pero aún bajo tratamiento
98: No Aplica

105. Motivo de la finalización de este último esquema de cualquier tipo de radioterapia suministrado en el periodo de reporte actual (aplica si registró la opción 2 de la pregunta anterior). Seleccione un sólo número (lo que primero ocurrió): Registre:
1: Toxicidad
2: Otros motivos médicos

3: Muerte
4: Cambio de EPS
5: Decisión del usuario, abandono la terapia.
6: Otros motivos administrativos
7: Otras causas no contempladas
98: No Aplica

INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE TRASPLANTE DE CÉLULAS MADRE HEMATOPOYÉTICAS (INCLUYE MÉDULA ÓSEA) EN EL PERIODO DE REPORTE ACTUAL

106. ¿Recibió el usuario trasplante de células progenitoras hematopoyética dentro del periodo de reporte actual?: Registre:
1: Sí recibió
98: No Aplica (verifique que en las variables 107 a 110 se registra No Aplica)

Aclaraciones
*No aplica trasplante propuesto, pero no realizado (se eliminó la opción 2) *No aplican trasplantes de órganos sólidos u otros no relacionados con progenitores hematopoyéticos.

107. Tipo de trasplante recibido: Registre:
1: Autólogo
2: Alogénico de donante idéntico relacionado
3: Alogénico de donante no idéntico relacionado
4: Alogénico de donante idéntico no relacionado
5: Alogénico de donante no idéntico no relacionado
6: Alogénico de cordón umbilical idéntico familiar
7: Alogénico de cordón umbilical idéntico no familiar
8: Alogénico de cordón no idéntico no familiar
9: Alogénico de dos unidades de cordón
98: No Aplica (respondió 2 o 98 en la pregunta anterior)

108. Ubicación temporal de este trasplante en relación al manejo oncológico: Este trasplante de células progenitoras hematopoyéticas fue:
95: Recaída

96: Refractariedad
97: Esquema de consolidación
98: No Aplica

Aclaraciones

*Recaída: paciente con criterios de remisión, al que nuevamente se le demuestra enfermedad activa. *Refractariedad: paciente sin criterios de remisión a pesar del manejo.

109. Fecha del trasplante: registre la fecha de realización del trasplante en el formato AAAA-MM-DD. Registre:
1845-01-01: No Aplica.

110. Código de la IPS que realizó este trasplante: registre el código de habilitación de IPS (disponible en la página web REPS – código de 12 dígitos incluido el cero inicial).
96: Trasplante fuera del país
98: No Aplica

INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE TRATAMIENTO COMPLEMENTARIO EN EL PERIODO DE REPORTE ACTUAL

111. El usuario, ¿recibió cirugía reconstructiva en el periodo de reporte actual?: registre:
1: Sí recibió cirugía
98: No Aplica (No recibió este tipo de cirugía, verifique que en las variables 112 y 113 se registra No Aplica)

Aclaraciones
*En casos en los cuales se realiza cirugía curativa y reconstructiva en el mismo tiempo quirúrgico, no se deben reportar las variables correspondientes a cirugía reconstructiva, solamente se deja el registro en las variables 76 o 80, según el caso. *No aplica cirugía reconstructiva propuesta más no realizada (se eliminó la opción 2)

112. Fecha de la cirugía reconstructiva: Fecha en que se realizó la cirugía en el formato AAAA-MM-DD. Si conoce sólo el año y el mes, registre el día 15.
1845-01-01: No Aplica.

113. Código de la IPS que realizó cirugía reconstructiva: registre el código de habilitación de IPS (disponible en la página web REPS – código de 12 dígitos incluido el cero inicial)
98: No Aplica

114. ¿El usuario fue valorado en consulta o procedimiento de cuidado paliativo en el periodo de reporte actual? (pueden haber sido múltiples), registre:
1: Sí fue valorado
2: No recibió

Aclaraciones
*Reporte la consulta con el profesional que tenga la especialidad de cuidados paliativos. *No aplican consultas o procedimientos propuestas, pero no realizadas (se eliminó la opción 3) *La atención paliativa aplica para todo tipo de cáncer y en cualquier estadio, no es exclusivo de estadios avanzados.

114.1. El usuario recibió consulta o procedimiento de cuidado paliativo en el periodo de reporte actual, por médico especialista en cuidado paliativo. Registre:
1: Sí fue valorado.
2: No recibió

114.2. El usuario recibió consulta o procedimiento de cuidado paliativo en el periodo de reporte actual, por profesional de la salud (no médico, incluye psicólogo) especialista en cuidado paliativo. Registre:
1: Sí fue valorado.
2: No recibió

114.3. El usuario recibió consulta o procedimiento de cuidado paliativo en el periodo de reporte actual, por médico especialista, otra especialidad. Registre:
1: Sí fue valorado.
2: No recibió

114.4. El usuario recibió consulta o procedimiento de cuidado paliativo en el periodo de reporte actual, por médico general. Registre:
1: Sí fue valorado.
2: No recibió

114.5. El usuario recibió consulta o procedimiento de cuidado paliativo en el periodo de reporte actual, por trabajo social. Registre:
1: Sí fue valorado.
2: No recibió

114.6. El usuario recibió consulta o procedimiento de cuidado paliativo en el periodo de reporte actual, por otro profesional de salud (no médico, incluye psicólogo) no especializado: Registre:
1: Sí fue valorado.
2: No recibió

Aclaraciones
*Se elimina la opción 3 (no recibió, aunque fue propuesta) de las variables 114.1 a 114.6.

115. Fecha de primera consulta o procedimiento de cuidado paliativo en el periodo de reporte actual: Registre la fecha de primera interconsulta o procedimiento en el formato AAAA-MM-DD. Si conoce sólo el año y el mes, registre el día 15.
1845-01-01: No Aplica.

116. Código de la IPS donde recibe la atención de cuidado paliativo en el periodo de reporte actual: registre el código de habilitación de IPS (disponible en la página web REPS – código de 12 dígitos incluido el cero inicial).
98: No Aplica

117. ¿Ha sido valorado el usuario por el servicio de psiquiatría en el periodo de reporte actual?:
Registre:
1: Sí fue valorado.
2: No, se ordenó, pero está pendiente
98: No aplica, no se ha ordenado valoración por psiquiatría

118. Fecha de primera consulta con el servicio de psiquiatría (para todos los usuarios) en el periodo de reporte actual: Fecha de primera interconsulta en el formato AAAA-MM-DD. Si conoce sólo el año y el mes, registre el día 15.
1845-01-01: No Aplica.

119. Código de la IPS donde recibió la primera valoración de psiquiatría en el periodo de reporte actual: registre el código de habilitación de IPS (disponible en la página web REPS – código de 12 dígitos incluido el cero inicial).
98: No Aplica

120. ¿Fue valorado el usuario por profesional en nutrición en el periodo de reporte actual?:
Registre:
1: Sí fue valorado.
2: No, se ordenó, pero está pendiente
98: No aplica, no se ha ordenado valoración por nutrición

121. Fecha de consulta inicial con nutrición en el periodo de reporte actual: registre la fecha en que se inició esta atención en el formato AAAA-MM-DD. Si conoce sólo el año y el mes, registre el día 15.
1845-01-01: No Aplica.

122. Código de la IPS donde recibió la valoración por nutrición, en el periodo de reporte actual: registre el código de habilitación IPS (disponible en la página web REPS – código de 12 dígitos incluido el cero inicial).
98: No Aplica

123. ¿El usuario recibió soporte nutricional?: registre:
1: Si recibió soporte nutricional enteral
2: Si recibió soporte nutricional, parenteral
3: Si recibió soporte nutricional enteral y parenteral (opciones:1 y 2)
4: No recibió soporte nutricional

Aclaraciones
*Vía de nutrición enteral: técnica de soporte nutricional administrada mediante sonda, directamente al sistema gastrointestinal. *Vía de nutrición parenteral: técnica de soporte nutricional administrada por vía venosa. *No es válido el reporte de fórmulas nutricionales de administración oral

124. ¿El usuario ha recibido terapias complementarias para su rehabilitación?
1: Si, Terapia física
2: Si, terapia de lenguaje
3: Si, Terapia ocupacional
5: 1 y 2
6: 1 y 3
7: 2 y 3
8: 1, 2 y 3
98: No aplica, no se han ordenado terapias.

Aclaraciones
*No aplican terapias propuestas, pero no realizadas (se eliminó la opción 4)

SITUACIÓN ACTUAL DEL USUARIO (A LA FECHA DE CORTE -1º de enero de 2026)

125. Tipo de tratamiento que está recibiendo el usuario a la fecha de corte (2026-01-01):
Registre:
1: Radioterapia
2: Terapia sistémica (incluye quimioterapia, anticuerpos monoclonales, terapia biológica, terapia hormonal)
3: Cirugía (reporte solo cuando el procedimiento se haya realizado a partir del 1 de noviembre de 2025)
4: 1 y 2
5: 1 y 3
6: 2 y 3
7: Manejo expectante pretratamiento
8: En seguimiento, luego de tratamiento durante el periodo

9: Antecedente de cáncer (no recibió ningún tratamiento, pero tiene como mínimo una consulta de seguimiento relacionada con el cáncer dentro del periodo)
10: 1, 2 y 3
11: Manejo de cuidado paliativo o terapia complementaria.
98: No Aplica (paciente se encuentra fallecido, abandonó el tratamiento, alta voluntaria o se encuentra desafiliado)

RESULTADO FINAL DE MANEJO ONCOLÓGICO EN ESTE PERIODO DE REPORTE

126. Resultado final del manejo oncológico en este periodo de reporte, luego de ser tratado en este periodo el usuario está en:

1: Pseudoprogresión (aplica solo para inmunoterapia)
2: Progresión o recaída
3: Respuesta parcial
4: Respuesta completa
5: Enfermedad estable
6: Abandono del tratamiento o alta voluntaria
7: Paciente en seguimiento por antecedente de cáncer
8: Pendiente iniciar el tratamiento luego del diagnóstico (fue definido por especialista o aún está pendiente por valoración oncológica inicial, en la cual se defina el tratamiento)
97: No aplicable en este periodo, aún bajo tratamiento inicial
98: No aplicable en este periodo, aún bajo tratamiento de recaída
99: No aplica, el paciente se encuentra fallecido, o se encuentra desafiliado

Aclaraciones
* Pseudoprogresión: aumento o aparición de lesiones por infiltración de células inflamatorias, con posterior disminución o desaparición de éstas, hecho que traduce en realidad la respuesta al tratamiento (aplica sólo para inmunoterapia). * Progresión o recaída: cuando hay un crecimiento detectado en el tumor mayor o igual al 25%. * Remisión (respuesta) parcial: disminución del tamaño de un tumor medible mayor o igual al 30%. *Remisión (respuesta) completa: desaparición de toda evidencia clínica de la enfermedad. Esto no siempre traduce curación. *Enfermedad estable: no remisión parcial ni progresión, es decir, el tumor aumentó menos del 25% y disminuyó menos del 30%. No cumple criterios de remisión parcial (disminución mayor o igual al 30%) ni de progresión (aumento del tamaño del tumor mayor o igual al 25%).

*Si se reporta el paciente con opción 7: Paciente en seguimiento por antecedente de cáncer, tener en cuenta que como mínimo debe haber tenido una atención en el periodo directamente relacionada con la gestión y seguimiento para el cáncer.

127. Estado vital al finalizar este periodo de reporte: Registre:
1: Vivo
2: Fallecido
99: Desconocido

128. Novedad ADMINISTRATIVA del usuario respecto al reporte anterior: Registre:
0: no presenta novedad con respecto al reporte anterior (vivo y afiliado a la entidad).
1: usuario ingresó a la EAPB en el periodo de reporte y ya tenía el diagnóstico de cáncer
2: usuario con un nuevo diagnóstico de cáncer entre el 2 de enero de 2025 y el 1 de enero de 2026
3: usuario con diagnóstico antiguo de cáncer que no había sido incluido en el reporte anterior
4: usuario que falleció
5: usuario que se desafilió
6: usuario para eliminar de la base de datos por corrección luego de auditoría interna o de CAC
7: usuario que firmó alta voluntaria del tratamiento
8: usuario con cambio de tipo o número de ID
9: usuario abandonó el tratamiento y es imposible de ubicar
10: usuario no incluido en reporte anterior y está fallecido en el momento del reporte actual
11: trasladado de IPS
12: usuario que es notificado con dos o más cánceres en este periodo
13: usuario no incluido en reporte anterior y está desafiliado en el momento del reporte actual
15: Comunidad migrante de la República de Venezuela
16: Usuario con cambio de CIE-10: aplica para casos con cánceres secundarios o no especificados en los que se define el primario o se especifica el tipo de cáncer.
17: Usuario identificado por cruce con fuentes externas, con diagnóstico de cáncer no gestionado por la EAPB.
18: Usuario identificado por cruce con fuentes externas, con diagnóstico descartado por la EAPB o fallecido /desafiliado no gestionado por la entidad sin diagnóstico confirmado de cáncer.
19: Paciente trasladado que fue glosado en periodo anterior, que **no** fue gestionado por la entidad en el periodo actual.

Aclaraciones

* Para el reporte de casos que cambian de tipo y número de identificación, se debe reportar el registro dos veces, el primer registro (con la identificación actualizada) con la novedad que corresponda al periodo de reporte y el segundo registro (con la identificación del periodo anterior) con la opción 8: usuario con cambio de tipo o número de ID, lo anterior con el fin de

evitar el reporte de omitidos en el proceso de cargue de la información. La CAC una vez recibida la información inactivara en el sistema el registro que fue reportado con la opción 8.

* La novedad 19, se creó exclusivamente para los casos con inconsistencia en el periodo anterior quienes fueron trasladados de entidad en el periodo actual y que no hayan sido gestionados por la entidad receptora. Este tipo de pacientes no serán auditados, pero sí serán requeridos para el próximo periodo.

* La novedad 6 (eliminados), se utiliza para eliminar de la cohorte casos requeridos "activoscac", prima sobre las demás novedades (incluso desafiliados y fallecidos), ya que después de revisión de la EAPB y la red de prestadores identifican que el paciente no tiene cáncer, por lo cual no pertenece a la cohorte.

* En los pacientes con diagnóstico confirmado que presentan estado vital fallecido, seleccionar la opción 4: usuario que falleció, cuando el paciente es "activocac", y utilizar la opción 10: usuario no incluido en reporte anterior y está fallecido en el momento del reporte actual, cuando el paciente es reportado por primera vez a la CAC, es decir, tipo de requerido diferente de "activo".

*Los pacientes con dos o más lesiones primarias que presentan estado vital fallecido, las líneas deben quedar con la novedad administrativa de fallecido, según corresponda. Esta novedad prima sobre las demás.

*En los pacientes vivos con diagnóstico de cáncer confirmado y que el estado de afiliación al finalizar el periodo es desafiliado, utilizar la opción 5: usuario que se desafilió, cuando el paciente es tipo de requerido "activocac", y la opción 13: usuario no incluido en reporte anterior y está desafiliado en el momento del reporte actual, cuando se trata de pacientes reportado por primera vez a la CAC, es decir, tipo de requerido diferente a "activocac".

*Los pacientes vivos con dos o más lesiones primarias que presentan estado de afiliación "desafiliado" en la misma entidad, las líneas deben quedar con la novedad administrativa de desafiliado, según corresponda. Esta novedad prima sobre las demás.

* En pacientes con diagnóstico de cáncer confirmado, sean reportados por primera vez a la CAC (nuevos) o reportados previamente con diagnóstico confirmado (anteriores), si su estado vital es fallecido y se mantiene la confirmación del diagnóstico, esta novedad administrativa prima sobre las demás.

*Sí el paciente cuenta con el diagnóstico de cáncer confirmado, puede utilizar la novedad administrativa según corresponda para paciente vivo, activo, desafiliado o fallecido (variable 128 opciones 0,1,2,3,4,5,7,9,10,11,12,13,15, y 16); En contraste, para dicho contexto no pueden utilizar las opciones 6, 17, 18, 19, ya que puede incurrir en calificaciones de no calidad en el proceso de auditoría, debido a que estas opciones que indican que tiene el diagnóstico descartado o en gestión.

*Sí el paciente se encuentra en gestión de confirmación o descarte del diagnóstico, puede usar las opciones 6, 17, 18 y 19. No puede usar las siguientes novedades opciones 0,1,2,3,4,5,7,9,10,11,12,13,15 y 16, debido a que estas son para paciente con diagnóstico confirmado; **el uso incorrecto de las novedades administrativas genera inconsistencias y datos de no calidad.**

*En los casos con clasificación tipo requerido "registro simplificado de datos", no de debe utilizar la novedad administrativa opción 17, ya que estos casos son informados por las entidades cuando tiene el diagnóstico de cáncer confirmado. En caso de identificar que un caso presentó descarte del diagnóstico, los deben reportar con novedad administrativa opción 18.

EXCLUSIVAMENTE PARA REQUERIDOS POR FUENTES EXTERNAS

A continuación, se describen aspectos para tener en cuenta para el reporte de los registros requeridos de fuentes externas (base de datos suficiencia UPC y casos notificados por fichas técnicas del instituto nacional de salud) para el periodo 2026:

* Los usuarios con diagnóstico de cáncer que fueron identificados a través de cruces con fuentes externas y son requeridos "diagnóstico no gestionado" para el periodo2026, que no tuvieron atenciones durante el periodo de reporte o no cuentan con la gestión y/o soportes suficientes para validar la confirmación o descarte del diagnóstico, deben ser reportados con la novedad administrativa 17. Estos casos no serán objeto de auditoría en el periodo 2026; sin embargo, la entidad tiene la responsabilidad de gestionar el diagnóstico para informar en el siguiente periodo, por lo cual son requeridos obligatorios para el siguiente periodo.

* Para los usuarios identificados por cruce de fuentes externas con posible diagnóstico de cáncer, pero que después de la auditoría interna llevada a cabo por la entidad, fue descartado, registrar la novedad administrativa 18 y disponer al proceso de auditoría los soportes en los cuales se evidencia que el diagnóstico de cáncer fue descartado. Estos casos serán objeto de verificación y lLos casos que no cuenten con soportes y usen esta novedad administrativa se aplicará inconsistencia.

* Si se trata de un usuario requerido por fuentes externas actualmente fallecido, que no fue gestionado y la entidad no cuenta con los soportes que permitan confirmar el diagnóstico, reportar con novedad administrativa opción 18.

* Si se trata de pacientes requeridos por fuentes externas, con diagnóstico confirmado y gestión en el periodo, reportar con la novedad que aplique, según su estado vital y de afiliación, se auditarán como casos nuevos.

* Recuerde que las novedades 17 y 18 para los usuarios requeridos después de cruces con fuentes externas, priman sobre las demás novedades.

*Los casos requeridos por fuentes externas y no gestionado periodo anterior, en los cuales el asegurador y el prestador realizan gestión en la búsqueda del paciente, pero no logran que acuda a la atención en salud para definir o descartar el diagnóstico de cáncer, se deben reportar con la novedad administrativa 17 (Diagnóstico no confirmado).

*Para aclaraciones de requeridos se recomienda revisar en el manual de auditoría la sección 4.1.2 validaciones de requeridos.

Por otra parte, en la siguiente tabla se describen los contextos para el uso de las novedades administrativas en los **pacientes vivos y activos** en la entidad.

Tabla 1. Selección de novedades administrativas en pacientes vivos y activos

Contexto de paciente vivo y activo	Reporte de las novedades
Paciente vivo y activo a quien se descartó el diagnóstico de cáncer, y no es requerido de fuentes externas	Reporte la novedad administrativa con la opción 6 en la línea a eliminar. Esta novedad prima sobre todas las demás.
Paciente vivo y activo con dos o más cánceres	Reporte la novedad administrativa con la opción 12 en las líneas (2 o más) que tenga el paciente. **Esta novedad prima sobre todas las demás en paciente vivo y activo con diagnóstico confirmado.**
Paciente vivo y activo con cambio de tipo y número de ID	Reporte una línea con la novedad administrativa opción 8 y otra línea con los datos actualizados de tipo y número de ID y con la novedad correspondiente al periodo.
Paciente vivo y activo con cambio de CIE-10	Reporte una línea con la novedad administrativa opción 16 y otra línea con el dato actualizado del CIE-10 y la novedad correspondiente al periodo.
Paciente vivo y activo con cambio de CIE-10 y con dos o más cánceres	Reporte la(s) línea(s) a ajustar con el CIE-10 antiguo y la novedad administrativa 16, luego reporte las líneas con el dato del CIE-10 actualizado y la novedad administrativa 12, paciente con dos o más cánceres.
Paciente vivo y activo en abandono y con cambio de tipo y número de ID	Reporte una línea con la novedad administrativa opción 8 y otra línea con los datos actualizados de tipo y número de ID y con la novedad de abandono.
Paciente vivo y activo en abandono y con traslado de EAPB, con diagnóstico antiguo de cáncer	Reporte en una línea con la novedad 9 (abandono).
Paciente vivo y activo con inconsistencia en el periodo anterior y cambio de entidad.	Reporte una línea con novedad 19 (paciente trasladado que fue glosado en periodo anterior, que no fue gestionado por la entidad en el periodo actual)

129. Novedad clínica del usuario a la fecha de corte: Registre:
1: Usuario que está en manejo inicial curativo
3: Usuario que finalizó tratamiento inicial y está en seguimiento
8: Abandono de tratamiento
9: Usuario firmó alta voluntaria
10: Usuario en manejo expectante antes de tratamiento
11: Usuario que está en manejo paliativo (incluye manejo de metástasis o de recaída)
12: Usuario fallecido o desafiliado

Aclaraciones
*La opción 11, recopila los pacientes con todos los tipos de cáncer, que reciben terapia con intención paliativa a la fecha de corte.

130. Fecha de desafiliación de la EAPB:
Registre la fecha en la que el usuario se desafilió de la EAPB en el formato AAAA-MM-DD
1845-01-01: No Aplica, el usuario no se desafilió

131. Fecha de muerte:
Registre la fecha en la que el usuario falleció en el formato AAAA-MM-DD
1845-01-01: No Aplica, el usuario no falleció o su estado vital no se conoce

Aclaraciones
*Si un paciente se encuentra fallecido y desafiliado, teniendo en cuenta que prima la novedad de fallecimiento, sólo reportar la fecha de muerte en variable 131 y comodín 1845-01-01 en fecha de desafiliación**.** *En los casos en que la entidad verifique y el paciente tenga estado vital vivo, pero BDUA lo reporte como estado vital fallecido, para el proceso de la auditoria disponer los soportes de las atenciones en salud y el soporte de la afiliación a la entidad.

132. Causa de muerte:
Registre:
1: Muerte asociada al cáncer
2: Muerte por patología clínica no relacionada al cáncer
3: Muerte por causa externa
4: Muerte por causa no conocida
98: No Aplica, usuario vivo o se desconoce su estado vital

133. Código único de identificación (BDUA-BDEX-PVS): Registre el código único serial de identificación BDUA- BDEX- PVS asignado al paciente por el Ministerio de Salud y Protección Social.

134. Fecha de Corte: Diligencie esta variable con la fecha 2026-01-01

Tabla 1. Control de cambios del documento

Versión N°	Fecha	Observaciones de los ajustes realizados
Emisión inicial	2026-02-13	Respecto al instructivo de reporte de información del periodo 2026 se realizaron los siguientes ajustes: • Actualización de las fechas que corresponden al periodo 2 enero de 2025 al 1 enero de 2026. • Aclaraciones de la población objeto de reporte de información. • Se incluyen aclaraciones en variable 16, 17, 20, 26, 45, 49, y 128.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CAC
Cuenta de Alto Costo

Fondo Colombiano de
Enfermedades de Alto Costo

@cuentadealtocosto

www.cuentadealtocosto.org